ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUの臨床倫理と終末期の意思決定



臨床倫理は特別な症例のための分野ではない。毎日の回診の中にある。

価値観を聴き、医師が提案し、手順で決める — なぜ大事か・言葉と原則・枠組みと意思決定能力・誰がどう決めるか・ACP・どう話すか・DNARと蘇生・差し控えと終了・緩和的抜管・看取りと死の判定・チームと公正・落とし穴・カルテの文例

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-10-27

ICUの臨床倫理は、特別な症例のときだけ開く分野ではありません。挿管するか、DNARをどう扱うか、家族にどう話すか、治療をどこまで続けるか。毎日の判断の多くに倫理の問いが含まれ、ICUで亡くなる患者の多くは、治療を「どこまで続けるか」を決めた後に亡くなります。決め方を誤ると、本人の望まない治療が続くか、救えたかもしれない治療が最初から差し控えられます。持ち帰るのは次の3点です。

✓ 要点 — 持ち帰る3つ

1. **DNARで決まるのは心停止時の蘇生だけ**。治療の範囲は「終末期かどうか」ではなく、多職種の4観点の検討と共同意思決定（SDM）で決め、迷えば期限付きの試行（TLT）にする（§5・§8・§9）
2. 面談は**価値観を聴いてから医師が推奨を伝え**、決定の重荷を家族に負わせない（§3・§7）
3. 終了するときは緩和ケアを先に準備し、抜管の前後の苦痛に薬で先回りして、家族とチームを支える（§10〜§12）

✓ 中心原則 — 全章を貫く考え方

相手に選ばせず、医師から提案する。ただし状況に応じて提案の強さを変える。提案と誘導を分けるのは、その土台に本人の価値観があるかどうかです。価値観を聴かずに推奨すれば誘導になり、価値観を聴いたうえで推奨すれば、価値観を医療行為に翻訳した提案になります。だから順番は、病状を伝える → 価値観を聴く → 専門家として推奨する、です [Lu MayoClinProc2020] [AHA2025 倫理編]。提案の強さの5段階と、強さを選ぶ3つの要素は§3にまとめました。

📚 関連資料（すべて公開ページ）

4学会合同ガイドライン（2026）

- 生命維持治療の終了と差し控え — 4学会合同ガイドライン2026｜解説ページ (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/jsicm-lst-guideline-2026/) 薬の全量とQ&Aの要点

家族との対話・ACP・DNAR

- なぜACPはうまくいかないのか — 3ステージ・4つの質問・予後の伝え方 (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/acp-three-stage/) 書籍『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』の要点 **まとめ** (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/acp-three-stage/)
- DNARは原因を問わず範囲を明示して運用する (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/dnar-scope/) 原疾患限定論の限界・入院時の確認・指示の書き方 **まとめ** (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/dnar-scope/)

関連するテーマの教材

- フレイルと高齢重症患者 (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/resident-frailty/) フレイルの測り方と判断表
- 心停止後ケア (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/resident-post-arrest/) 神経予後の伝え方
- ICUの人間的ケア（Humanization） (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/resident-humanizing-icu/) 家族とスタッフのケア
- PICSとICU退室後のフォロー (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/resident-pics/) 生存者と家族の退室後

最新の動き（随時更新）

この領域は2025〜2026年に大きく動きました。日本では4学会合同ガイドラインが10年ぶりに全面改訂され、DNARの射程も学会が明文化しました。新しい順に並べます。まず最新の5件を示し、残りは「すべて見る」で開けます。

表1｜臨床倫理の最新の動き — 新しい順

時期	出典	要点
2026-10	Intensive Care Medicine（PICNL-ICUの追加解析）	不適切なケアを感じる医療者は感情的消耗（β 0.4）と離職意向（OR 1.6）が高い。決定を先送りする文化が押し上げ、相互尊重が押し下げる（§12）
2026-10	Critical Care（韓国・WLST 5.5%のコホート）	2025年ERC/ESICMアルゴリズムの特異度は97.1%だが偽陽性1例（ECMO後）。「判定できない」28.5%の97%は不良転帰で、「良好の可能性」は半々（§5）

時期	出典	要点
2026-10	入院時の一律のDNAR確認を見直す臨床医の論考と、引用された一次資料	入院時の一律のDNAR確認は、指示がなければ全例フルコードという構造への防衛反応。入口では推定意思だけを確認し、経過の中で範囲の明確なDNARに落とす。記録は「DNARの有無」から「共有された認識の進捗」へ（§6・§15）
2026-09	日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会「生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン」	2014年の3学会の提言を全面改訂。終末期を定義せず、多職種の臨床倫理的検討とSDMの2本柱で決める。差し控えと終了は倫理的に同等、「中止」は「終了」に。DNARは心停止時のCPRに限る。緩和ケア別編で抜管時の薬まで示した（§1・§9・§10）
2026-09	JAMA（脳死を家族にどう伝えるか）	「生命維持装置」ではなく「臓器を支える治療」と言い換える。判定に立ち会った家族は理解の満点到達が66%対20%と高く、心理的負担は増えなかった（RCT 1本）（§11）
2026-09	Critical Care（Perspective）	無益なCPRを短時間だけ行う「time-limited code」は、誠実さも害の軽減も満たさず、倫理的な妥協にならない（§8）
2026-08	Critical Care（Perspective）	死の判定で確認しているのは irreversibility（戻せない）ではなく permanence（もう戻さないという決定）（§11）
2026-08	Intensive Care Medicine（SSC2026のエディトリアル）	敗血症ガイドラインが goals of care・事前指示・期限付きの試行（TLT）・緩和ケアを Good Practice Statements として明文化した（§10）
2026-08	Critical Care（28研究の質的系統的レビュー）／Crit Care Explor	臓器提供に立ち会う家族を最も傷つけたのは手順の設計。死亡告知と提供の依頼を分ける。心停止後提供でも終末期ケアの中身は変えない（§11）
2026-06	Critical Care Medicine（34論文の系統的レビュー＋エディトリアル）	スローコードは82.4%が「欺瞞」と判断。蘇生を強制する法や方針も同じく非倫理的（§8）
2026-06	Critical Care Medicine（PICNL-ICU、オランダ47 ICU）	医療者の26%が「不適切な治療をしている」と感じていた。複数人が一致した患者は6か月死亡 aOR 3.86（§5）
2026-06	Intensive Care Medicine（SCCM2026・ESICM2025 高齢ICU患者のエディトリアル）	強い推奨はゼロ。一致したのは「老年医学的ケアモデルをICUに組み込む」だけ（§13）
2026-02	Journal of Intensive Care（豪州の終末期ケア）	豪州では差し控えと終了は法的に同等で、家族は無益な治療を要求できない。ただし無益の判断は担当専門医の合意が条件（§13）

時期	出典	要点
2025-10	AHA 2025 心肺蘇生ガイドライン 倫理編（Circulation）	4原則を均衡の枠組みとし、年齢を生命維持治療を制限する唯一の決定因子にしない。informed nondissent（反対がなければ医療者の方針で進める）を示し、スローコードを否定した（§3・§8）
2025-06	JAMA Network Open（4学術病院122人の面接）	モラルディストレスを生むのは病院文化・階層・「治療を減らす手続き」の不在。デブリーフィングは緩和であって予防ではない（§12）
2025-02	Critical Care Medicine（SCCM 成人ICUの家族中心ケアガイドライン2024）	17ステートメントのうち強い推奨は1つだけ。面会を緩和した方針をICUの既定にする（§7・§11）
2025-02	日本救急医学会雑誌（高齢者救急に関する用語の統一概念）	DNAR指示が有効なのは心停止時のみ。BSCをDNARや緩和ケアの言い換えに使わない。「予想された急変」を定義（§2・§8）

時期は論文の公開月です。出典の詳細は末尾の主要文献にあります。

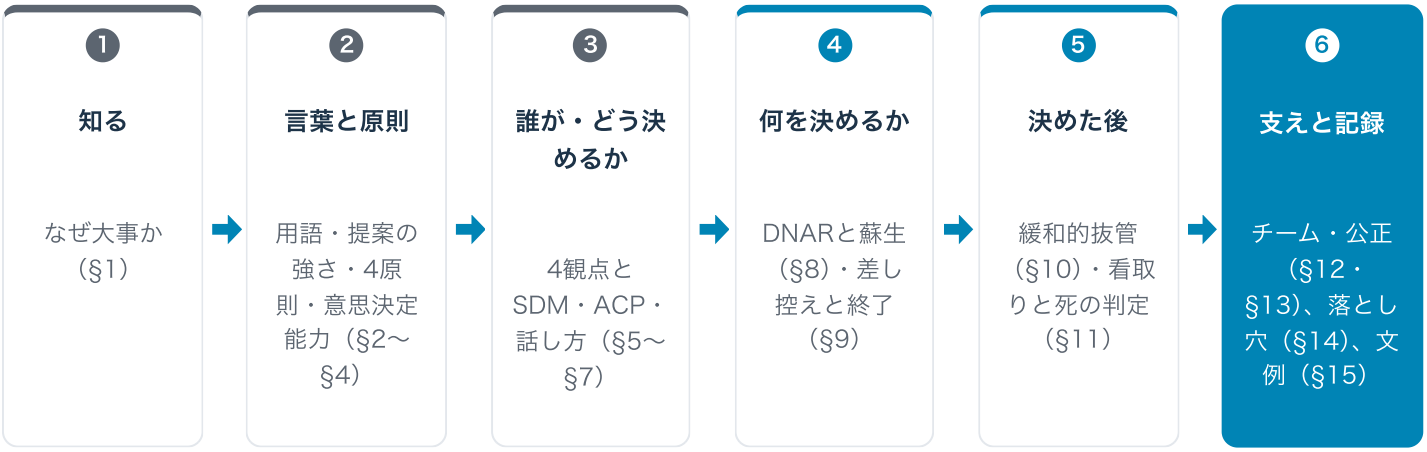


図1. ICUの臨床倫理の地図 — 知る → 言葉と原則 → 誰が・どう決めるか → 何を決めるか → 決めた後 → 支えと記録。

図の読み方 — 左の3段は、治療の話をする前にそろえておく前提です。「何を決めるか」から先に始めると、DNARの拡大解釈や「全部やるか、やらないか」の二者択一に陥りやすくなります [4学会GL2026]。

§1 なぜ大事か — ICUの死の多くは「決めた後」に起き、日本は終了をためらってきた

欧州では治療を制限した後の死が9割に達し、治療制限は例外ではなく標準になりました。日本では「一度始めたらやめられない」という不安が強く、終了より差し控えが選ばれてきました。この章の結論は、治療制限は看取りの開始ではなくゴールの定義し直しであり、2026年の4学会合同ガイドラインがその決め方の基準線になった、ということです。



治療制限は看取りの開始ではなく、ゴールを定義し直すこと。決め方が結果を左右する。

この章のポイント

1. **治療制限は看取りの開始ではなく、ゴールの定義し直しと知る**
2. **「やめられないから始めない」をしない**
3. **4学会GL（2026）の手順を判断の基準線にする**

1-1. 治療制限は例外から標準になり、制限後に生きて退院する人も増えた

欧州22 ICUを16年あけて比べたEthicus-2では、治療制限を伴う死が68.3%から89.7%へ増え、治療制限を受けた患者の生存退院は5.5%から20.4%へ上がりました（表2） [Ethicus-2 JAMA2019]**。**

治療制限は「看取りの開始」ではなく、「治療のゴールを定義し直す行為」です。差し控えた後に限れば生存退院は8.9%から34.9%に上がっています [Ethicus-2 JAMA2019]。一方で、終了（withdraw）の後は24時間以内に98%が亡くなっており、倫理的に同等でも（§9）、差し控えと終了は臨床的にはまったく違う経過をたどります。

表2｜Ethicus-2（1999→2016、欧州22 ICU） — 制限は標準になり、制限後の生存も増えた

指標	1999〜2000年	2015〜2016年	読み方
治療制限を伴う死	**68.3%**	**89.7%**	差21.4%（95%CI 19.2〜23.6）
制限なしのまま亡くなった患者	**31.7%**	**10.3%**	フルコードでの死は少数派に
治療制限後の生存退院	**5.5%**	**20.4%**	制限は死の決定ではない
差し控え後の生存退院	**8.9%**	**34.9%**	差し控えた3人に1人は退院
終了後24時間以内の死亡	—	**98%**	家族の到着・別れの調整は決定の前に

対象は西欧に偏った22 ICUで、そのまま日本に当てはまるとは限りません [Ethicus-2 JAMA2019]。

1-2. 「やめられないから始めない」の害 — 日本では初期治療までためらわせてきた

2014年の3学会ガイドラインは人工呼吸器を含む生命維持装置の終了を認めていましたが、法的リスクの不安と、終了後の緩和ケアの指針がないことから終了はほとんど行われず、「やめられないなら最初から始めない」という判断が救命できたかもしれない患者の治療をためらわせる危険がありました [4学会GL2026 説明文]。

旧版は「終末期」を4つの例示で定義し、旧Q&Aは「近いうち」をおおよそ2〜3日以内としていました。その結果、生命維持治療を続けている限り終末期にならず、望まない治療が死の直前まで続く運用が残りました [4学会GL2026 説明文]。日本では「欧米ではICUの死の多くが終了の後に起こるが、日本には終了から死までを管理するプロトコルがない」ことも、踏み切れない実質的な理由だと指摘されています [伊藤 人工呼吸2023]。

1-3. 2026年の基準線 — 終末期を定義せず、手順で決める

4学会合同ガイドラインは「終末期」をあえて定義せず、多職種の臨床倫理的検討と厚労省プロセスガイドラインに沿ったSDMという手順を示し、差し控えと終了を倫理的に同等とし、DNARは心停止時の蘇生に限ると明文化しました（表3） [4学会GL2026]。

表3｜2014年版から2026年版で変わったこと — 結論ではなく、決め方を示す

項目	2014年版（3学会の提言）	2026年版（4学会合同GL）
終末期	定義し、4つの例示	あえて定義しない。病態は「医学的側面」として個別に評価
判断の枠組み	医療チームが終末期と判断	多職種の臨床倫理的検討（4観点）＋SDM（§5）
差し控えと終了	—	倫理的に同等（§9）
TLT	記載なし	明記。一度始めた治療もやめられる（§9）
緩和ケア	「緩和的措置」の一言	緩和ケア別編で薬・用量・家族ケア・医療者ケア（§10〜§12）
用語	延命措置・中止	生命維持治療・終了。「消極的安楽死」「BSC」は使わない（§2）
作り方	記載なし	修正デルファイ法（3ラウンド）＋パブリックコメント。推奨の強さは付かない

！このガイドラインの読み方

推奨の強さもエビデンスの確実性も付かない、手順を示す臨床倫理のガイドラインです（作成委員28名の修正デルファイ法3ラウンド）。プロセスが患者・家族のアウトカムを改善するかの実証データは乏しく、手順が守られているかを測る仕組みもまだありません（§14） [4学会GL2026]。

1-4. 法律はないが、手順を守ることが法的な不安への答えになる

日本には終了・差し控えを定めた法律がなく、判例と、厚労省プロセスガイドラインや学会ガイドラインという soft law が拠り所で、2007年以降、救急・集中治療の終末期医療で全国報道された刑事事件や警察の介入は確認されていません

[4学会GL2026 説明文]。

有罪になった2件（東海大学病院事件・川崎協同病院事件）は、塩化カリウムや筋弛緩薬で意図的に死期を早めた事例でした。不起訴の2件は意図的な行為はなかったものの、許容される終了かどうかが不明瞭で警察の介入を招いています [4学会GL2026 説明文]。ガイドラインに沿った適切なプロセスなら、終了・差し控えが刑事裁判で違法とされることはないと考えられる、と説明文は述べています。ただし、従えば法的に免責されるとは書いていません [4学会GL2026 Q48]。話し合いの過程の記録が最大の備えになります（§9-5・§15）。

根拠を見る（表4：4つの事件）

表4｜終末期医療をめぐる4つの事件 — 分かれ目は意図的に死期を早めたかどうか

事件	何をしたか	結果
東海大学病院事件（1991）	多発性骨髄腫の末期。家族の求めで治療を外した後、ベラパミルと塩化カリウムを静注	1995年 殺人罪で有罪。傍論で治療終了の許容要件（死が避けられない末期状態・本人の意思表示）を示した
川崎協同病院事件（1998）	心停止後の昏睡。家族の求めで抜管し、苦悶様呼吸に鎮静薬、さらに筋弛緩薬を投与	2009年 最高裁で有罪確定。推定意思に基づく終了が許される場合を認め、末期状態に限定しないと解しうる
射水市民病院事件（2000〜2005）	終末期のがん等の患者7名の人工呼吸器を外した	2009年 不起訴（死期を早める行為ではない、殺意なし）
道立羽幌病院事件（2004）	本人の意思確認なく、家族への説明も不十分なまま人工呼吸器を外した	因果関係が認められず不起訴

法で線を引く国との違いは§13-4で扱います。

§2 言葉をそろえる — 同じ言葉を同じ意味で使う

臨床倫理の議論が噛み合わない原因の多くは、病態の複雑さではなく言葉のずれです。同じ「DNAR」を医師と看護師が違う範囲で読んでいれば、どれだけ話し合っても合意は形になりません。この章の結論は、用語の定義と「避ける言い方」を先にそろえ、Goals of Care は介入の可否ではなく価値観から話す、ということです。

この章のポイント

1. **DNARは心停止時だけの指示で、「治療をしない」ではない**
2. **「中止」ではなく「終了」、BSCは使わず、終末期は判断の根拠にしない**
3. **GOCは介入の可否ではなく、価値観から話す**

2-1. 用語の定義と使い方

用語は表5の意味で使います。なかでもDNARの拡大解釈は日本で最も多い誤りで、学会が名指しで警告しています（範囲の図と根拠は§8） [JSICM勧告2017] [JJAAM2025]。

表5｜臨床倫理の用語 — 定義・使い方と、避ける言い方

用語	定義・使い方	避ける言い方
治療と指示		
DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）	心停止時に心肺蘇生（胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬）を試みない指示。有効なのは心停止時だけで、「治療をしない」ではない [JSICM勧告2017]	「急変時DNR」「DNARなので挿管しない」「DNARを取る」
partial DNAR	胸骨圧迫だけ行って挿管しない、といった部分的な蘇生。救命につながらないので行わない [JSICM勧告2017]	「心マだけ」
スローコード	意図して不完全に行う形だけの蘇生。患者への危害で、家族への欺瞞にあたる。行わない（§8） [AHA2025 倫理編]	「形だけやる」「家族への配慮」
生命維持治療	生命を維持するのに必要とみなす治療。人工呼吸器と補助循環だけでなく、昇圧薬・ペースメーカー・人工栄養・水分補給・透析・輸血・輸液も状況によって含まれる [4学会GL2026]	「延命治療」「延命措置」
差し控え／終了	開始しないこと（withholding）と、行っている治療をやめること（withdrawal）。倫理的には同等に扱う（§9） [4学会GL2026]	「治療中止」「消極的安楽死」

用語	定義・使い方	避ける言い方
終末期	4学会GLはあえて定義しない。終了・差し控えは終末期に限らず、治療・ケアのゴールから判断する [4学会GL2026]	「終末期なので」を判断の根拠にする
ゴールと話し合い		
Goals of care（治療・ケアのゴール）	本人の価値観に照らして治療で何を目指すか（延命・機能回復・苦痛の緩和・自宅に帰る など）。個々の介入の可否そのものではない（2-3） [Secunda JGIM2020]	「GOC＝DNARの確認」「予後不良」の婉曲表現
無益（futility）	その人にとって利益が見込めないこと。医療資源やコストの話ではない	「もったいない」「意味がない」
ACP（人生会議）	本人の価値観を家族・医療者と共有し続けるプロセス。書類を作ることではない（§6） [厚労省GL2018]	「ACPを取る」
SDM（共同意思決定）	価値観を聴く段階は本人・家族が主導し、選択肢を勧める段階は医療者が主導する、という役割分担で一緒に決める [Elwyn BMJ2010]	選択肢を並べて選ばせる
意思決定能力	選択を伝える・理解する・自分のこととして認識する・比較して考える、の4過程を決定ごとに評価する臨床判断（§4） [Ganzini JAMDA2004]	診断名・認知機能の点数・「医師の勧めに従うか」で決める
推定意思	本人が意思を示せないとき、家族等の話から推定する本人の意思。「家族の希望」とは区別して記録する	「家族がDNARを希望」
家族等	法的な親族に限らず、本人が信頼する人（親しい友人など）を含む [厚労省GL2018]	—
提案の形と選択肢		
informed assent	価値観と病状を踏まえて医療者が「○○はしません」と方針を伝え、質問を受ける。無益性が明らかで価値観もはっきりしているときに使う（§3） [Curtis JAMA2020]	—
informed nondissent	医療者が方針を示し、反対があれば言ってもらい、なければその方針で進める。拒否権を明示して残す（§3） [AHA2025 倫理編]	—
informed consent	選択肢と推奨を説明し、同意を得る。ICの主体は患者	「医師が患者にICした」
TLT（time-limited trial）	期間と評価項目を決めて特定の治療を試行し、結果で継続・増強・減弱・終了を決める。期限で自動的に終了も延長もしない（§9） [4学会GL2026]	「とりあえず様子を見る」
BSC（best supportive care）	本来はがん臨床試験で両群に等しく行う最低限の医療。中身が見えず「見放した」と受け取られるので4学会GLは使わない。代わりに続ける・控える・終える治療を書く [4学会GL2026 説明文]	「ここからはBSCで」

DNRはDNARの旧来の呼び方、フルコードは心停止時にCPRを行う方針を指します。

2-2. 避ける言葉と、代わりに使う言葉

厳密な言葉を都合のよい婉曲表現にすり替えると、元の意味とのずれが記録にも会話にも残らないので、表6の言い換えをそろえます [4学会GL2026 説明文]。

表6｜言葉の対応表 — 使わない言葉と、代わりに使う言葉

避ける言葉	代わりに	理由
治療の「中止」	生命維持治療の「終了」	「中止」は再開を前提にすると読まれうる。症状緩和は続くので「生命維持治療の」と付ける
延命治療・延命措置	生命維持治療	どこからが延命か区切れない
BSC	具体的に何を続け、何を控え、何を終えるかを書く	内容が具体的でなく、「見放した」と受け取られやすい
「ここからは緩和ケアで」	緩和ケアを並行して続ける	緩和ケアは予後ではなく必要性で行う（§10）
「医師が患者にICした」	「説明し、同意を得た」	ICの主体は患者。3要素は十分な説明・理解・自由意思に基づく同意
「急変時DNAR」	「心停止時はCPRを行わない」	DNARの範囲は心停止時だけ
「GOC＝DNARの確認」	本人が大切にしていること → 今の文脈での実現可能性 → 方針	GOCは価値観から導く包括的な目標（2-3）

日本救急医学会は、担当医が近い将来に生じうると予想できる病態の変化を「予想された急変」と定義し、事前の指示があればそれに従うことも可能としました [JJAAM2025]。

2-3. GOCは4要素で — 最初に価値観、最後に介入

1987〜2018年の文献214本を分析した系統的レビューは、GOCを①包括的な目標 ②本人の価値観と優先順位 ③臨床的な文脈 ④介入の判断を導く、の4要素がそろったものと定義し、この順序を崩すと面談は「DNARを取る場」に退行します（表7）[Secunda JGIM2020]。

表7｜Goals of Careの4要素 — 順序が本体

要素	内容	面談での位置
①包括的な目標	延命か快適さかの二択ではなく、複数の目標を同時に追ってよい	最初に聞く
②本人の価値観と優先順位	何を大切にしてきたか。自宅に帰る・自分でできる・家族の行事など	最初に聞く
③臨床的な文脈	今の病状で何が可能か。可逆性と予後の見立て	次に説明する
④介入の判断を導く	③を踏まえ、②に沿う介入は何かを一緒に考える	最後に話す

実際の面談では、医師が「ゴールの話をする」と宣言した場面でも、発話の4%未満しか本人の意向や価値観に触れていませんでした[Secunda JGIM2020]。GOCという言葉を使っただけでは、価値観を聴いたことにはなりません。カルテでも「GOC＝DNAR」と省略せず、「本人が大切にしていること」「今の文脈での実現可能性」「そこから導かれる方針」を分けて書きます（§15）。

ここで使う言い方

「すべてやりますか、やめますか」ではなく、「〇〇さんがこれまで一番大切にしてこられたことは何でしょうか」から入ります。4学会GLの緩和ケア別編は、「これができないまま生きていくのは考えられない、と思うのはどんなことですか」という問いを例に挙げています[4学会GL2026 別編]。価値観の聴き方の実際は§6、面談の型は§7で扱います。

§3 中心原則 — 選ばせずに医師から提案し、提案の強さを状況で変える

「心臓マッサージを希望しますか」「挿管しますか」。相手を尊重しているように見えるこの聞き方は、ゴールに寄与しないと分かっている選択肢にも検討の価値があるように聞こえさせ、決断の重さを家族に預けてしまいます。この章の結論は、価値観を聴いてから医師が提案すること、そしてその強さを状況に合わせて選ぶことです。この原則は後の全章の土台になります。

この章のポイント

1. **提案と誘導を分けるのは、土台に本人の価値観があるかどうか**
2. **提案の強さは5段階。中立の「どうしますか」は使わない**
3. **強さは、医学的な確かさ・価値観の明確さ・委ねたい気持ちの3つで選ぶ**

3-1. 提案と誘導を分けるのは、価値観を聴いたかどうか

価値観を聴かずに「CPRはしないほうがよい」と言えば、判断が正しくても誘導になります。価値観を聴いたあとなら、同じ言葉は価値観を医療行為に翻訳した提案になります [Lu MayoClinProc2020]。

SDMは、双方が同じ情報を同じように扱うことではありません。価値観を聴く段階では本人・家族が主で医療者は聴き役、治療を選ぶ段階では医療者が主になります [Elwyn BMJ2010]。最初から「はい／いいえ」で聞くと、CPRの次は昇圧薬、透析、人工栄養と、答えようのない質問が続きます [Lu MayoClinProc2020]。

× 中立に選ばせる

「人工呼吸器をつけますか。ご家族で相談してください」

○ 価値観を受けて提案する

「伺ったお考えからすると、機械につなぐことはせず、苦しさを取ることに力を注ぐのがよいと考えます。反対があればおっしゃってください」

3-2. 提案の強さの5段階

提案には強さの段階があり、強い順に informed assent・informed nondissent・推奨して意見を求める・やや弱い推奨と並び、中立の「どうしますか」はゴールに寄与しないと分かっているときには使いません（表8）。

表8｜提案の強さの5段階 — 強い順。5は使わない

強さ	言い方の例	使う場面・出典
1 informed assent	「そういうことであれば、○○はしません。何かご質問はありますか」	医学的に利益がないことが明らかで、価値観もはっきりしているとき [Curtis JAMA2020]
2 informed nondissent	「○○はしない方針で進めます。反対があればおっしゃってください。なければこの方針で進めます」	拒否権を明示して残し、決定の重荷は医療者が引き受ける [AHA2025 倫理編]
3 推奨して意見を求める	「○○はしないほうがよいと思います。いかがですか」	推奨ははっきり伝え、決定は一緒に行う
4 やや弱い推奨	「○○はおすすめしません」	医学的な見込みに幅があるとき
5 使わない	「○○はどうしますか」（中立の はい／いいえ）	ゴールに寄与しないと分かっているなら、決断を丸投げすることになる

AHA 2025が示した informed nondissent は、家族に決断の重荷を負わせず、医療者が一方的に決めるのでもなく、明確な拒否権を残す方法です [AHA2025 倫理編]。日本ではまだ一般的ではないので、1・2の強さを使う前に、家族が決定を医療者に委ねたいか、どの決定を委ねるのかを具体的に確かめます。

3-3. 強さを選ぶ3つの要素

提案の強さは、医学的な確かさ・本人の価値観の明確さ・家族が決定を医療者に委ねたいか、の3つで選びます。

強さを選ぶ3つの要素

1. 医学的な確かさ — その治療が本人に利益をもたらさないことが明らかか
2. 本人の価値観の明確さ — 価値観を聴く段（§6の Stage 2）で、ゴールが聴けているか
3. 家族が決定を医療者に委ねたいか — 日本では1・2の強さを使う前に、委ねたいかどうかと、どの決定を委ねるかを具体的に確かめる

3つがそろわないときは強さを下げます。価値観が聴けていないなら、提案の前に§6の順で聴き直します。

§4 倫理の枠組みと意思決定能力 — 4原則で名指しし、4分割法で並べ、能力は決定ごとに見る

倫理の問題は「何かがおかしい」という違和感から始まります。その違和感をチームで扱える形にするのが、4原則とJonsenの4分割法です。そして、誰が決めるのかが曖昧なまま話し合いを始めると、議論は必ず迷走します。この章の結論は、対立は4原則で名指しし、症例は4分割法で並べ、本人の意思決定能力は「全か無か」ではなく決定ごとに評価する、ということです。

この章のポイント

1. **倫理的対立は、4原則のどれとどれがぶつかっているかで名指しできる**
2. **症例は4分割法（医学的適応・患者の意向・QOL・周囲の状況）で並べる**
3. **意思決定能力は決定ごとに4つの過程で評価し、医学的助言に反する選択は能力欠如の根拠にしない**

4-1. 4原則は、ぶつかっている価値に名前を付ける道具

臨床倫理の4原則は自律尊重・善行・無危害・公正で、ICUの倫理的対立はこのどれとどれがぶつかっているかを必ず同定できます（表9） [FCCS]。

表9｜臨床倫理の4原則 — ICUで問題になる場面

原則	意味	ICUで問題になる場面の例
自律尊重（autonomy）	患者が自己決定する権利	本人が挿管を拒む／意思決定能力が揺れる／事前指示がある
善行（beneficence）	患者にとって最大の利益を生むよう行動する義務	回復の見込みが不確かな治療を始めるか
無危害（nonmaleficence）	利益のない治療・検査で害を与えない義務	苦痛を伴うだけの処置、無益なCPR
公正（justice）	すべての患者を公平・公正に扱う義務	ベッドの配分・トリアージ、障害や年齢による無自覚な差

4原則は答えを出す公式ではありません。たとえば「家族が全部やってほしいと言う」場面は、家族の希望（自律尊重の代理）と、患者に害を与えない義務（無危害）がぶつかっている、と言い換えるだけで議論が進みます。FCCSの教材は、終末期に生命維持は終了されうるが**ケアは決して終了されない**、とまとめています [FCCS]。

4-2. Jonsenの4分割法で、症例をもれなく並べる

4分割法は、症例を医学的適応・患者の意向・QOL・周囲の状況の4つの窓から眺めるワークシートで、多職種で議論する前の整理に使います（図2） [Jonsen]。

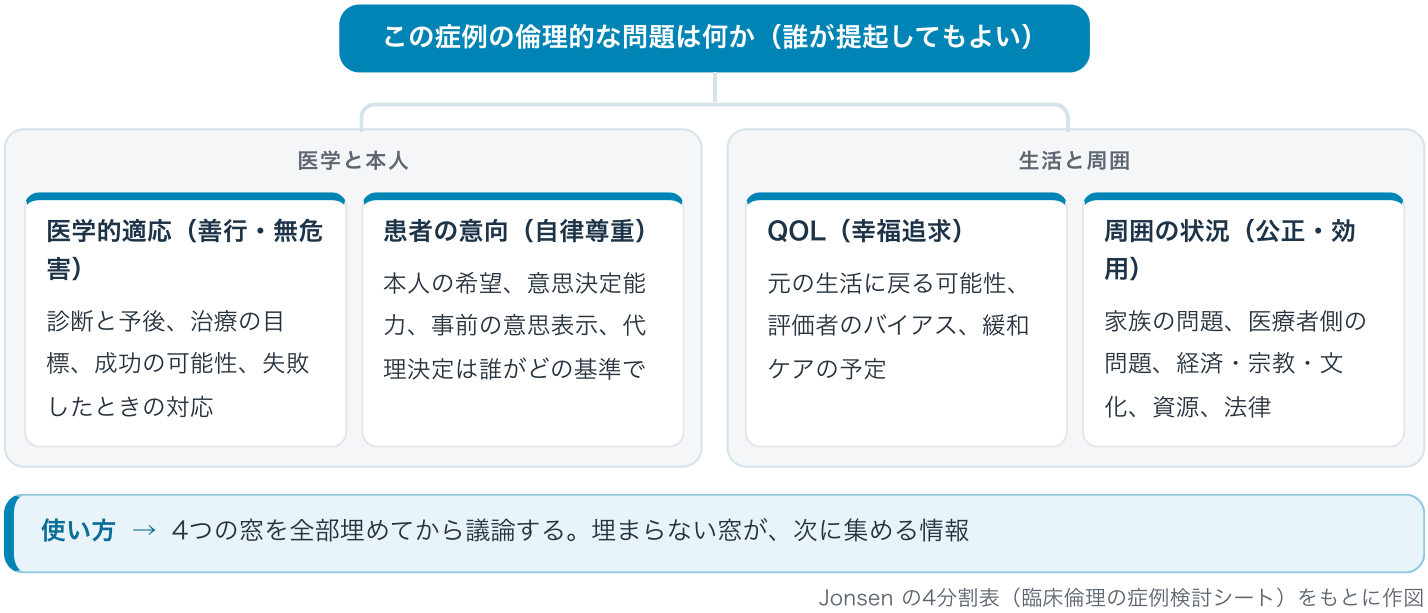


図2. Jonsenの4分割法 — 4つの窓を全部埋めてから議論する。

図の読み方 — 左は医学と本人の窓、右は生活と周囲の窓です [Jonsen]。4学会合同ガイドラインの「臨床倫理的検討の4観点」（医学的側面・患者の意向・QOL・周囲の状況）は、この4分割と同じ骨格です（§5）[4学会GL2026]。

QOLの窓には「評価者が患者のQOLにバイアスをかけて見ていないか」という問いが入っています。これは§5-5と§13で扱う先入観（エイブリズム）への最初の歯止めです [Jonsen]。

4-3. 対立したら、7つの手順で進める

倫理的対立には、医学的事実の明確化 → 該当する原則の同定 → 意思決定者の明確化 → 誠実なコミュニケーション → コンセンサス形成 → 必要時の倫理委員会 → 記録、という手順で臨みます [FCCS]。

対立したときの手順

1. 医学的事実を明確にする（診断・予後・治療の選択肢）
2. どの倫理原則が関係しているかを同定する
3. 誰が意思決定者かをはっきりさせる（4-4・§5）
4. 明確で誠実なコミュニケーションを続ける（§7）
5. チーム内・家族とのコンセンサスを作る
6. 決まらなければ倫理コンサルテーション・倫理委員会に助言を求める（§5-6）
7. 検討の過程を記録する（§9-5・§15）

4-4. 意思決定能力は、決定ごとの臨床判断

capacity（意思決定能力）は決定ごとに医療者が行う臨床判断で、competency（行為能力）は裁判所が下す法的判断です。能力は診断名でも検査の点数でもなく、その決定について①選択を伝えられる、②理解する、③自分のこととして認識する、④比較して考えられる、の4つの過程で評価します（表10） [Ganzini JAMDA2004]。

表10｜意思決定能力の評価 — 何が本体で、何が代用にならないか

方法	使い方	根拠・注意
4過程の評価	これが本体	担当する臨床医が行い、最終責任を持つ
説明の有無の確認	先に確かめる	情報が与えられていないことは能力の欠如ではない
時間軸の確認	忘れやすい	欠如はしばしば一時的。回復が見込めれば決定を待ち、回復したら本人に戻す。鎮静薬や挿管で低下して見えることもある
認知機能検査（MMSEなど）	代用にならない	高得点でも能力を欠く人、低得点でも一部の決定ができる人がいる
診断名（認知症・統合失調症など）	単独では否定できない	欠如の最多の原因はせん妄と認知症だが、能力が保たれていることも多い
「医師の勧めに従うか」	根拠にならない	助言に反したことは能力欠如の根拠ではない

ベッドサイドではCURVESの語呂も使われます（表11）。認知機能が低下していることは、意思決定能力がないことと同じではなく、「ない」という判断は容易には下せません [CURVES]。

表11｜意思決定能力の評価 CURVES — 全か無かではない

項目	確かめること
C：Choose	複数の治療方針から自由に選択できるか
U：Understand	治療の利益・害、代替手段、治療による変化を理解できるか
R：Reason	受け入れる／断る理由を説明できるか
V：Value	本人の価値判断と決定が矛盾していないか
E：Emergency	本当に差し迫った状況か
S：Surrogate	代理人、または本人の意思を記した文書があるか

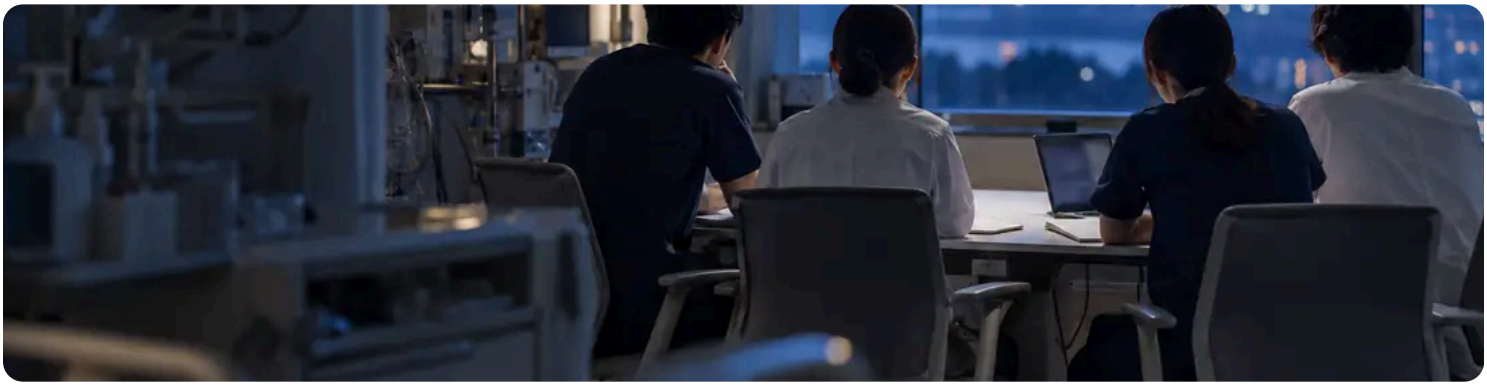
4-5. ICUでは能力が時間で動く — 清明な時間を選び、具体的に記録する

せん妄と鎮静で能力は数時間単位で動くので、清明な時間帯に面談を合わせ、緊急でなければ回復を待ちます [Ganzini JAMDA2004]**。**

4学会合同ガイドラインも、鎮静薬や挿管で能力が一時的に低下して見えることがあり、説明の工夫や環境調整で可能な限り引き出すこと、能力が十分でなくても価値観や選好は持っていることが多い、と書いています（Q16） [4学会GL2026]。カルテには「意思決定能力なし」とだけ書かず、「〇月〇日〇時、△△の同意について、4つの過程のうち□□が確認できなかった」と、決定・時刻・欠けた過程を具体的に残します [Ganzini JAMDA2004]。本人が意思を示せないときに誰がどう代わって決めるかは、§5-2の4つの場面で扱います。

§5 誰がどう決めるか — 多職種の4観点とSDMの2本柱で、一人で決めない

決めるのは担当医一人でも、家族一人でもありません。医療・ケアチームが4つの観点で検討し、本人・家族等と話し合って一緒に決めます。この章の結論は、2本柱の手順を踏み、予測と決定を分け、現場の違和感と先入観を点検し、決まらなければ臨床倫理コンサルテーションに助言を求める、ただし決定は代行させない、ということです。



決めるのは担当医一人でも家族一人でもない。4観点を多職種で話し、全員に発言の機会を。

この章のポイント

1. **4観点を多職種で話し、全員に発言の機会を保証する**
2. **SDMは本人の意思にどこまで近づけるかで4つの場面に分け、「ご本人ならどう言うか」を問う**
3. **予測と決定を分け、違和感と先入観を点検する。決まらなければコンサルへ**

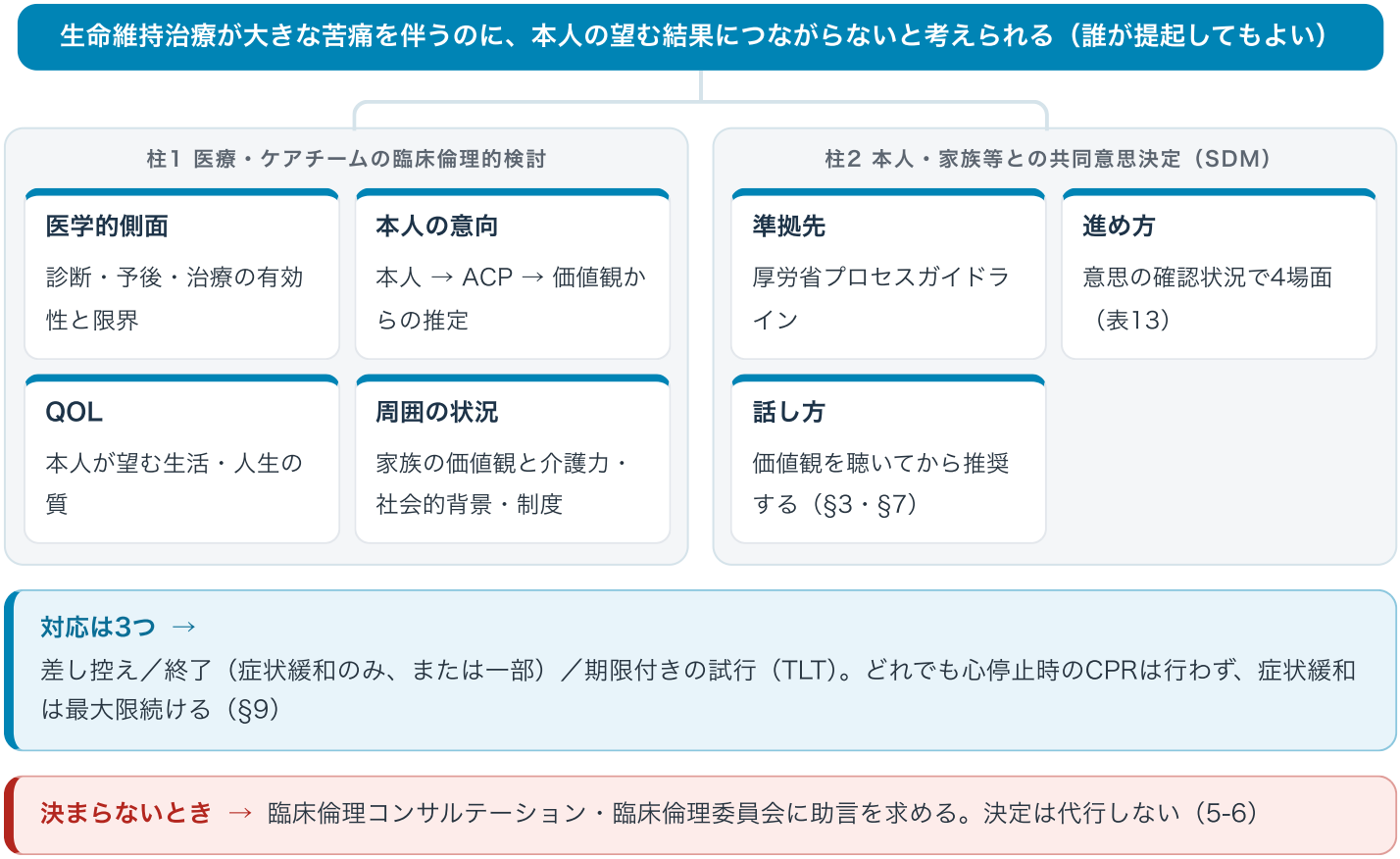


図3. 生命維持治療の終了・差し控えを決める手順 — 2本柱で検討し、3つの対応から選ぶ。

図の読み方 — 上のきっかけから、左のチーム内の検討と右の本人・家族との話し合いを並行して進めます[4学会GL2026]。下の青い帯が選べる対応、最後の帯がどちらかの柱で合意できないときの相談先です。患者本人が終了を希望した場合も、自己決定だけに依拠せず、この2本柱で総合的に判断します（Q54）。

5-1. チームの検討は4観点をもれなく、全員に発言の機会を

臨床倫理的な検討とは医学的側面・本人の意向・QOL・周囲の状況の4観点をもれなく話すことで、その患者に関わるすべての診療科と多職種、かかりつけ医や在宅の医療・ケア従事者まで加わり、全員に公平な発言の機会と心理的安全性を保証します（表12）[4学会GL2026]。

表12｜臨床倫理的検討の4観点 — 医療者の偏見を外して、もれなく

観点	検討する内容
医学的側面	診断・予後・治療の有効性と限界を客観的に評価する。各疾患の専門家の見解を踏まえる
本人の意向	意思を示せれば十分な説明を受けたうえでの意向。示せなければACPの記録（事前指示書を含む）。それも無ければ価値観から推定する
QOL	本人の望む生活・人生の質を知り、どう担保するかを検討する
周囲の状況	家族の価値観と介護力、社会的・文化的背景、法制度・病院体制を把握し、必要な社会的支援を考える

4観点は§4-2のJonsenの4分割と同じ骨格です。「多職種カンファ」の実態は理想から遠いことがあります。フランスのICUで差し控えを議論するカンファを実測したところ、実質14分のうち医師が94%を話し、看護師・看護助手の発言は1分（5%）でした[Tarcy ICM2022]。司会が発言を明示的に他職種へ振り、患者の情報は事前に共有して、その場は議論に使います。医師の方針を追認するだけの形式的な場は、4学会GLの趣旨に反します（Q62）[4学会GL2026]。

5-2. SDMは、本人の意思にどこまで近づけるかで4つの場面に分ける

厚生労働省のプロセスガイドラインに沿い、本人の意思を確認できるか、推定できるか、推定もできないか、家族等がいないかで進め方を変え、どの場面でも「最善」は第三者が決める利益ではなく本人の価値観に即した最善で判断します（表13）[4学会GL2026]。

表13｜SDMの4つの場面 — 「あなたならどうするか」ではなく「ご本人ならどう言うか」

場面	進め方
本人の意思を確認できる	能力を評価し（§4-4）、説明して合意する。能力がなくても、それまでのACPが今の状況に当てはまれば尊重する
確認できないが推定できる	家族等とチームが推定した意思を尊重する。ACPの状況が今と違っても、希望や価値観は推定の根拠になる
推定もできない	家族等と十分に話し合い、本人にとって最善の方針をとる。状態や評価が変わるたびに繰り返す
身元不詳・身寄りがない	年齢や外見の偏見を排し、過去の意向を最大限尊重する。終了・差し控えはチームや臨床倫理委員会が公正で透明な手続きで判断する

2018年の改訂で、意思を推定する「信頼できる者」は家族から**家族等**（親しい友人や事実上のパートナーなど）に広がり、複数でもかまいません（Q5・Q50） [厚労省GL2018]。

代理の人に問うのは「ご家族はどうしたいですか」ではなく「ご本人ならどう考えるでしょうか」です。家族の意向に介護や経済的な負担、年金などの事情が影響していないかにも注意し、優先するのは本人の価値観です（Q6・Q18） [4学会GL2026]。代理で決める家族の理解には偏りがあり、前向き研究では代理意思決定者の19%がICU医療をほとんど理解しておらず、ほぼ半数がケアの内容をよく知らないまま重い決定に関わっていました [Jabaley CritCare2026]。一度に大量の情報を渡すより、段階的に確かめながら進めます。

日本では事前指示に法的効力がなく、意思決定代理人の法的な定めもありません。成年後見人に医療同意権は含まれないと一般に理解されています。

表14｜迷う場面の次の一手（4学会GL2026のQ&Aから） — 一度で決めきらず、一人に背負わせない

場面	確かめること	次の一手
本人と家族の意見が違う	家族の意向に介護・経済的負担や年金の事情が影響していないか	本人の価値観を中心に調整し、必要なら第三者の助言を求める（Q6・Q18）
「お任せします」と言われる	情報の差が原因ではないか	専門用語を避け、選択肢と利点・不利益を釣り合いよく示して理解を確かめる（Q19）
意思が揺れる	揺れは自然なこと	再面談と再評価を前提にし、家族に強い決断力を求めない（Q20・Q21・Q29）
本人が終了を希望する	自己決定だけに依拠していないか	医学的妥当性を含む検討とSDMで総合的に判断する（Q54）
公的支援とつながらない孤立した患者	診療記録・生活歴・知人や関係機関	医療ソーシャルワーカーと連携し、単独で判断しない（Q27）

5-3. 予後の数字は「情報」、決定は価値観で — 予測と決定を分ける

予後モデルに基づいて治療の縮小や終了を決めることは医療者の倫理的責任が禁じると明言されており、重症度スコアを治療制限の理由としてカルテに書かず、予測は家族と共有する情報、決定は価値観と合意で行います [Bein ICM2023]。

「偽陽性ゼロ」という報告も、分母を見て伝えます。心停止後の神経予後予測で「不良マーカー2つ以上なら偽陽性ゼロ」とされた研究は良好転帰が33例しかなく、rule of three（0/nの95%上限はおよそ3/n）により、真の偽陽性率は95%の確からしさで10.6%以下としか言えません [Xu CritCare2026]。家族には「外れたことがない」ではなく「10人に1人まで外れうる不確実さが残る」と伝え、時点を固定して再評価します。

WLSTがほとんど行われない環境でも同じです。WLSTが5.5%の韓国の単施設コホート271人に2025年ERC/ESICMアルゴリズムを当てはめると、「不良の可能性が高い」110人のうち良好転帰は1人（VA-ECMO離脱直後の境界的なNSEが効いた例）で、特異度は97.1%、95%CIの下限は85.1%でした [Cho CritCare2026]。ECMO・溶血・鎮静が絡む症例では、2指標がそろっても交絡を確かめて

から伝えます。反対側の数字も説明に効きます。「良好の可能性」群で実際に良好だったのは50%で、「判定できない」28.5%の97.2%は不良転帰でした。「判定できない」を「希望がある」と言い換えず、EEG・MRI・NSE再検と時間をかけた観察を提案する根拠として使います。

「反応がない」も「意識がない」と同じではありません。行動上は反応のない急性脳損傷患者の15〜25%には、脳波やfMRIでしか検出できない隠れた意識（covert consciousness）があり、それがある患者では12か月後に自立まで回復した割合が44%対14%と高くなります [Egawa JIntensiveCare2024]。家族にはこの一文をそのまま伝え、72時間以内の断定を避けて、時間をおいて繰り返し評価してから話し合いを進めます。予後予測が治療の終了を通じて自らの予測を的中させる「自己成就的予言」の議論は、心停止後ケア（別資料）の§5-4に譲ります。

5-4. 複数の医療者の違和感 — 「不適切な治療では」は予後のシグナル

オランダ47 ICUの医療者1,058人の26%（276人）が調査当日に「不適切な医療を提供している」と感じており、複数の医療者が同じ患者について一致して報告した場合、その患者の6か月死亡は aOR 3.86（95%CI 1.23〜12.16）でした [PICNL-ICU CCM2026]。

理由の首位は分配的正義（70%）、次いで治療量と期待される転帰の不釣り合い（66%）でした。1人だけの報告では有意な関連はありません。リスクを高めたのは看護師であること（aOR 1.78）と、終末期の意思決定を避ける文化（aOR 1.92）でした。ただし患者本人のQOLやICU入室の後悔には差がなく、この感覚は「ICUに来るべきでなかった」の根拠にはなりません [PICNL-ICU CCM2026]。現場の違和感を個人の感情として流さず、複数人の一致を拾ってGOCを見直すきっかけにすることが、この研究の実務的な結論です。違和感を抱えた医療者自身をどう守るかは§12で扱います。

5-5. 先入観を点検する — 「この人はどうせ」が評価を歪める

障害のある人を無自覚に価値が低いものとして扱う前提（エイブリズム）は、自律尊重・善行・無危害・公正という誰も反対しない4原則を、歪んだまま治療制限の正当化に使わせます（表15） [Taccone ICM2023]。

表15｜先入観が評価を歪める3つの経路 — 障害は能力の欠如を意味しない

経路	起きること	点検の問い
自律性の否定	家族や医療者が「この人の最善は自分たちが知っている」と想定する	本人に直接、その決定について聞いたか
合理的配慮の欠如	伝えられない苦痛が興奮と読み替えられ、鎮静で処理される	文字盤・筆談・タブレットなどの補助具を試したか
知識の欠如	障害を「終末期」「一律にQOLが低い状態」と誤認し、公正を持ち出して治療を絞る	同じ病状で障害のない人にも同じ基準を当てるか

医療者の推定するQOLはあてになりません。脊髄損傷の調査では、重度の損傷を負っても生きていてよかったと思うと答えた救急医療者は18%でしたが、実際の生存者本人は92%が「生きていてよかった」と答えていました [Gerhart AnnEmergMed1994]。面談とカンファで足す3つの問い、判断の根拠にしてはいけないもの、高齢者の扱いは§13でまとめます。

5-6. 決まらなければコンサルへ — 4つの場面で呼び、決定は代行させない

チームでゴールが決まらない、本人・家族等と合意できない、家族等の中でまとまらない、患者の意思が分からず家族等もいない、のいずれかでは臨床倫理コンサルテーションや臨床倫理委員会に助言を求めますが、決定は代行されず、チームと本人・家族等に残ります [4学会GL2026]。

安楽死にあたるかもしれないと医療者が悩む場面でも、コンサルテーションや倫理委員会を使いやすい体制が望まれます [ICUとCCU2022]。呼ぶことは失敗ではなく、手続きの一部です。家族との対立は、呼ぶ前にどの層で起きているかを見立てます（§7-6）。

臨床倫理委員会は、適切なプロセスを踏んだ決定であれば、刑事・民事で訴追されたときにチームを守る役割を持つとされ、医療安全委員会とは独立して運用するのが望ましいとされます（注釈2・Q61） [4学会GL2026]。

§6 ACPとGoals of Care — 価値観を先に聴き、治療の話は最後に

治療の選択肢から話し始めると、話は「生きるか死ぬか」の二択になります。先に聴くべきは、その人が何を大切にして生きてきたかです。この章の結論は、ACPは書類ではなく繰り返す話し合いのプロセスであり、面談は病状 → 価値観 → 推奨の順に進めて価値観の段を飛ばさない、ということです。

詳しくは なぜACPはうまくいかないのか — 3ステージ・4つの質問・予後の伝え方 (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/acp-three-stage/) 書籍『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』の要点　**まとめ** (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/acp-three-stage/)



治療の選択肢より先に、その人が何を大切にしてきたかを聴く。

この章のポイント

1. **ACPは書類ではなく、繰り返す話し合いのプロセス**
2. **病状 → 価値観 → 推奨の順に進め、価値観の段を飛ばさない**
3. **入院時は推定意思の確認にとどめ、事前指示の枚数を成果にしない**

✓ 入院時は推定意思の確認にとどめる

入院の入口で一律にDNARを確認しない。生命の脅威が差し迫っていなければ、本人が大事にしてきたこと・望まないと話していたことを「何か伺っていますか」と聞くだけにし、コードステータスは「暫定フルコード（状況により随時検討）」と書いて話し合いの進捗を残す。範囲の明確なDNARは、悪化の兆しや家族の問いなど、経過の中で必要になったときに決める（§8）。

詳しくは DNARは原因を問わず範囲を明示して運用する §5 (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/dnar-scope/#s5)
入院時の確認の仕方　**まとめ** (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/dnar-scope/#s5)

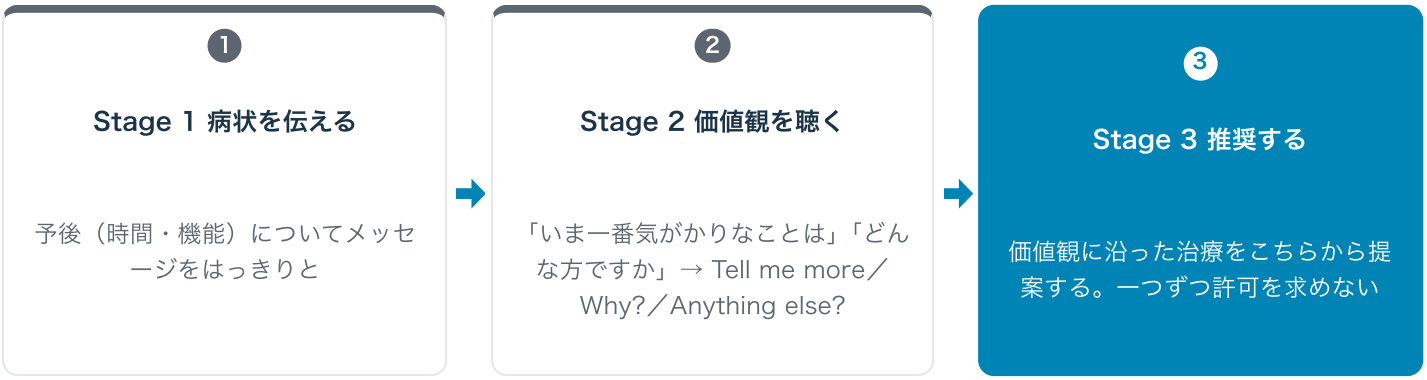
6-1. ACPは、繰り返し話し合い、そのつど共有するプロセス

2018年の厚生労働省ガイドライン改訂は、本人の意思は変わりうるので、望む医療・ケアや生き方を日頃から繰り返し話し合い、そのつど文書にして本人・家族等・医療ケアチームで共有することを求めました [厚労省GL2018]。

同じ改訂で、名称は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」となり、在宅や介護の現場も対象に入りました。意思を伝えられなくなる前に、意思を推定する人を決めておくことも求めています [厚労省GL2018]。ACPで聴くのはGOCの4要素のうち最初の2つ、包括的な目標と本人の価値観です（§2-3）。

6-2. 3ステージで話す — 病状、価値観、推奨の順

3ステージプロトコルは、病状の説明 → 治療ゴールの設定（価値観を聴く）→ 治療オプションの相談、の順に進め、手前の段を済ませてから次に進みます（図4） [Lu MayoClinProc2020]。



Lu E, Nakagawa S. Mayo Clin Proc 2020 の3ステージプロトコルをもとに作図

図4. 3ステージプロトコル — 最も飛ばされやすいのは Stage 2。

図の読み方 — よくある失敗は、Stage 1 の直後に「人工呼吸器をつけますか。ご家族で相談してください」と Stage 3 に飛ぶことです [Lu MayoClinProc2020]。Stage 2 を飛ばすと議論が生死の二択になり、差し控えや終了の判断が格段に難しくなります。Stage 3 で主導が医療者に移る理由と提案の強さは§3、面談の5段階の型は§7-2にあります。

× 許可を一つずつ求める

「心臓マッサージはどうしますか」「抗菌薬を続けたいですか」

○ 価値観に沿って推奨する

「抗菌薬は続けましょう。ただ、苦しませないために心臓マッサージはしません。よろしいですか」

6-3. ACPは書類ではない — 価値観を家族と共有し続けること

事前指示書が実際に効くには、本人が自分の価値観を分かっている・代理人がいる・代理人がそれを知っている・書類がある・その場に書類と代理人がある・医師が適切に話を進める、という条件がすべてそろう必要があります [ACP書籍2024]。

各条件が9割の確率で満たされても、全部そろうのは0.9の7乗で約48%にとどまります。書類を作ったことで「もう話さなくてよい」となり、家族が本人の思いを聞く機会を失うこともあります [Auriemma JAMAInternMed2022]。だから根幹は、本人が自分の価値観を言えることと、それを**できるだけ多くの家族と共有しておくこと**です。元気なうちに将来の治療の選択（Stage 3）まで決める必要はなく、その時が来たら、共有された価値観をもとに家族と医療者で選びます [ACP書籍2024]。

表16｜ACPで尋ねる4つの質問 — 望む上限と、許容できる下限を探る

順	尋ねること	ねらい
1	楽しみにしていること	上限を探る。「価値観は」と聞くより答えやすい
2	生きがい	大切にしているものをさらに深く聞く
3	状態が悪くなったときに一番気がかりなこと	下限に向かう。「悪くなったとき」という前置きをこちらから添える
4	こうなったら生きていたくない、という状態	許容できる下限。伝わらなければ具体例を挙げる

4番目の質問は、死が差し迫ったICUの場面では文脈に合わないので使わず、Stage 2 の他の質問で下限を探ります [ACP書籍2024]。

6-4. 事前指示があっても、ICUの判断に届くとは限らない

フランスの生命維持治療の制限カンファレンス15回では、事前指示を表明していた患者は0名、自分で意思表示できた患者は1名でした [Tarcy ICM2022]。

事前指示書の枚数を成果にすると、この落差を見落とします。大切なのは、ICUに入ったあとも価値観を聴き、記録に残し続けることです。入院時の確認を推定意思にとどめる理由も同じです（この章の冒頭の枠）。

§7 どう話すか — 聴いてから推奨し、決定の重荷を家族に負わせない

決め方の手順が正しくても、話し方を誤れば家族には「決めさせられた」という傷が残ります。倫理的な判断の多くは、家族との会話の中で形になります。この章の結論は、深刻な知らせの直後に決定を求めず、聴いてから推奨し、「決めたのはご家族です」と言わず、対立は「困った家族」と呼ぶ前にどの層で起きているかを見る、ということです。

詳しくは なぜACPはうまくいかないのか — 3ステージ・4つの質問・予後の伝え方 (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/acp-three-stage/) 書籍『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』の要点　**まとめ** (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/acp-three-stage/)



深刻な知らせの直後に、重要な決定を求めない。

この章のポイント

1. **悪い知らせの直後に決定を求めない**
2. **理解と大切なことを聴いてから推奨を伝え、「決めたのはご家族です」と言わない**
3. **対立は課題 → プロセス → 関係の順に移る。関係の層に入る前に手を打つ**

7-1. 深刻な知らせの直後、家族の脳は意味を受け取れない

言葉の意味が届くより先に扁桃体と島皮質が「危険」を登録し、カテコラミンとコルチゾールが注意を狭めて作業記憶を止めるので、沈黙・怒り・無反応は「理解の悪さ」ではなく生理的な過負荷のサインです [Rusinova ICM2026]。

知らせを伝えるときの3つの約束

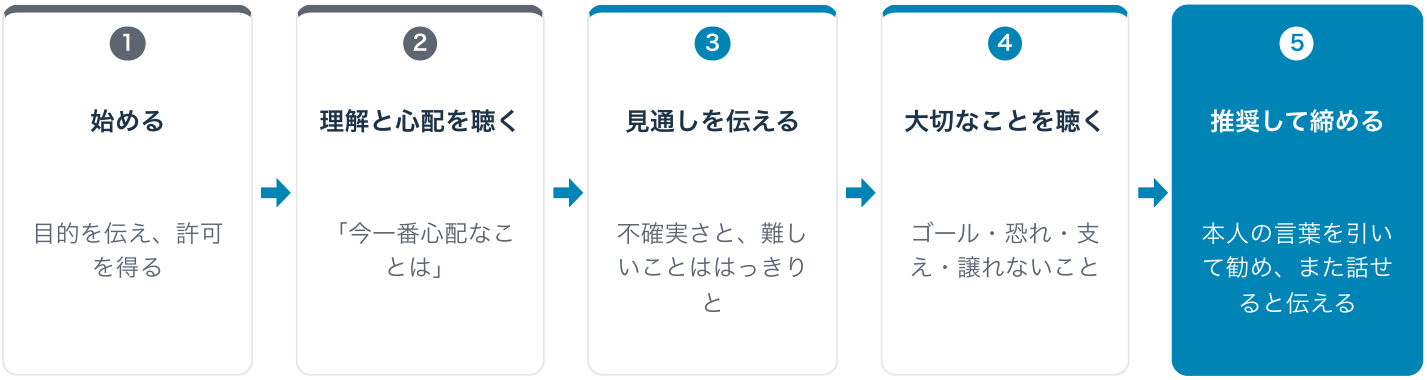
1. その時間帯に重要な決定を求めない。「では、どうされますか」を告知の直後に置かない
2. 見出しは1文で短く直接に伝え、意図して間を置く
3. 「わかりましたか」ではなく「ここまでで受け取られたことを教えてください」と聞き、返ってきた言葉をカルテに書く

ただしこの総説は仮説生成型の概念モデルです [Rusinova ICM2026]。悪い知らせの伝え方の骨格にはSPIKESを使い、Perception → Invitation の順に「まず聞く」こと、感情には解決ではなく言葉で応答すること（NURSE：命名・理解・承認・支持・探索）を押さえます [Baile Oncologist2000]。

静かな個室・全員分の椅子・手の届くティッシュはケアの前提ですが、個室そのものが「悪い知らせを聞く部屋」として記憶され、避けたい場所になる家族もいます [Maringer ICM2018]。

7-2. 面談の型 — 許可を得る、聴く、見通しを伝える、大切なことを聴く、推奨する

4学会GLの緩和ケア別編は、目的を伝えて許可を得る、理解と心配を聴く、見通しを伝える、大切なことを聴く、本人の言葉を使って推奨を伝える、の5段階を示し、医療側が一方的に説明を始めないことを要にしています（図5） [4学会GL2026 別編]。



4学会GL2026 緩和ケア別編 第1章の話し合いの進め方を5段にしたもの。言い方の例は表17

図5. 面談の5段階 — 説明の前に聴き、推奨は最後に。

図の読み方 — 灰色の2段は医療者が話す前に相手の受け止めを知る段です [4学会GL2026 別編]。§6-2の3ステージ（病状 → 価値観 → 推奨）と同じ順序を、面談の進行として細かくしたものです [Lu MayoClinProc2020]。

表17｜面談の言い方の例 — 本人の言葉を拾って、推奨につなげる

段階	言い方の例（4学会GL2026 緩和ケア別編）
始める	「今後予想されることをお伝えし、あなたにとってどのようなことが大切かをお聞きしながら、これからの治療やケアの方向性について一緒に考えていきたいと思うのですが、よろしいでしょうか？」
理解と心配を聴く	「今一番心配になられていることはどのようなことですか？」「病状について、どのようにとらえておられますか？」
見通しを伝える	「そうでないとよいのですが、残された時間が日単位〜週単位くらいになってきている可能性があることを心配しています」
大切なことを聴く	「普段の生活で一番楽しみにしていることはなんですか？」「もしお話しすることが難しくなった場合、どなたに、あなたの意思を推定して話し合ってほしいですか？」
推奨して締める	「〇〇がとても大切だとおっしゃいましたね。それを考慮に入れると、現在の病状では◎◎をお勧めします」「この方針をどう思われますか？」

説明者が正面に座るなら、看護師は本人・家族と説明者の間（90度の位置）に座ります。心情を打ち明けられたら「わかります」と即答せず沈黙を置き、感情にはNURSEで応じます [4学会GL2026 別編]。本人に意識があれば、家族より先に本人に聞きます。死が近いと判断された意識清明な患者の気がかりで最も多かったのは「治療の目標を話し合いたい」でした [Kentish-Barnes ICM2023]。

7-3. 決定の重荷を家族に負わせない — 「決めたのはご家族です」ではなく「医学的な結論をご家族と確認しました」

治療の終了に家族が関わると「死のタイミングに自分が関わった」という決定の残滓（decisional residue）が残ることがあり [Choi CritCare2026]**、家族のPTSD症状は単一の出来事ではなく、ICU滞在の全体にわたる引き金の積み重なりから生じます** [Kentish-Barnes ICM2026]**。**

「死のタイミングを自分が決めてしまった」という感覚は、医学的に正しい説明をしても消えません。3か月時点でPTSD症状のある家族17人への面接では、入室前の生活史から死後の遺体との対面まで、引き金が疾患の軌跡全体に散らばっていました [Kentish-Barnes ICM2026]。終了は「家族が決めたこと」ではなく「医学的に到達した結論を家族と確認したこと」として言語化し、記録にもそう残し、「安楽死ではない」ことも言葉にします。§3の原則どおり医療者側から推奨を伝えることは、家族の負担を減らす手段でもあります。一方、誰がそろってからにするか、何時にするかを家族に選んでもらった経験は、良い記憶として語られていました。

7-4. 予後は「わかりません」で済ませず、時間の単位で伝える

「どれくらいですか」と聞かれたら、聞く準備ができているかを確かめ、正確には分からないが目安は伝えられると前置きし、数時間〜数日・数日〜数週・数週〜数か月・数か月〜数年のどの単位かで答えます [ACP書籍2024]。

どの単位かの見当もつかないことは、実際にはほとんどありません。伝えた後は沈黙を置き、気まずさから情報を話し足さないようにします。驚きなどの感情が出たらNURSEで応じ、受け止めが済んでいれば価値観の話（Stage 2）に進みます [ACP書籍2024]。予後の数字と決定を分ける考え方は§5-3にあります。

7-5. 公式の面談と、議題のない日々の対話を使い分ける

ICUの医師の役割は医学情報の唯一の供給源から、信頼を築き情報と誤情報の海を家族と一緒に渡る案内人へ移り、節目の公式面談に加えて、議題を決めない短い日々のcheck-inが重視されるようになりました（表18） [Ashana ICM2026]。

表18｜公式面談と日々のcheck-in — 同じ型でやろうとしない

項目	公式の家族面談	日々のcheck-in
いつ	入室後早期・TLTの期日・方針を変えるとき	毎日、面会のたびに数分
議題	あり。図5の5段階とGOCの4要素を順に踏む	なし。聴くことに徹する
参加者	担当医・担当看護師・主な意思決定者	その場にいる医療者と面会者
出てくること	予後・方針・介入の可否	宿泊費・休業・症状など医療の外の困りごと
記録	説明の内容・理解・同席者・推定意思の根拠（§9-5）	ソーシャルワーカーなどへつなぐ情報があれば申し送る

家族が訴える満たされないニーズは、意思決定上の葛藤より、患者の症状・経済的な困窮・スピリチュアルな不安のほうが多いと報告されています [Cox CCM2023]。家族面談を、立場の異なる当事者が合意を作る「交渉」の場として捉え直す視点もあります [Tuinman ICM2026]。

7-6. 対立は3層で見立てる

ICUの対立は「何をすべきか（課題）」→「誰がどう決めたか（プロセス）」→「信頼と敬意が壊れたか（関係）」の3層を移動し、関係の層に入ると解決は格段に難しくなります（表19） [Jabaley CritCare2026]。

表19｜対立の3層 — 層を見誤ると打ち手も外れる

層	問われていること	典型的なことば	打ち手
課題	何をすべきか	「透析は続けるべきだ」	情報の共有と選択肢の整理
プロセス	誰がどう決めたか	「そんな話、聞いていません」	決め方と決定者を明らかにする
関係	信頼と敬意が壊れたか	「この病院は信用できない」	調停・第三者の関与。だから手前で止める

「困った家族」というラベルを貼る前に、どのプロセスが壊れていたかを見ます。「困った家族」の多くはプロセスの不全から生まれます。家族に会う前にチーム内で見解をそろえることも勧められていますが、単独の効果を示すエビデンスはありません [Jabaley CritCare2026]。4学会GLの緩和ケア別編も、対立は価値観の違いよりコミュニケーション不足から生じることが多く、話し合いを重ねれば90%以上の事例で合意に至ると述べています [4学会GL2026 別編]。それでも決まらないときの相談先は§5-6です。

7-7. 家族支援の研究 — 専任の伝え役は効かず、死の前後に会うことが効いた

多職種の家族支援（PARTNER）やコミュニケーション・ファシリテーターのRCTは家族の心理症状を減らせませんでしたが、死が近い患者の家族に死の前・最中・後に医師と看護師が会う3ステップ支援は、6か月後の遷延性悲嘆を21%から15%に減らしました（表20） [Kentish-Barnes Lancet2022]。

表20｜家族支援の主な試験 — 動いたのは対話の質と、死の前後の関わり

試験	規模	結果	読み方
PARTNER（多職種の家族支援）	**1,420例**	6か月のHADSは差なし（11.7 vs 12.0）。コミュニケーションの質は改善（69.1 vs 62.7）、ICU滞在は短縮（6.7 vs 7.4日）	心理症状は動かないが、質と資源は動く [White NEJM2018]
コミュニケーション・ファシリテーター	**449例**	6か月のHADS-うつの差 −0.07	専任の伝え役の新設は行き詰まった [Creutzfeldt CCM2026]
看護師主導の介入（系統的レビュー）	**14研究・2,885家族**	不安・うつ・PTSDは改善せず、コミュニケーションの質と在院日数が改善	同じ方向の結果 [Li CCM2026]
3ステップ支援（クラスターRCT）	**875人・34 ICU**	遷延性悲嘆21%→15%（OR 0.6、95%CI 0.4〜1.0）	差の実体は死後の面談（対照29% vs 介入85%） [Kentish-Barnes Lancet2022]

20年の家族支援RCTは、コミュニケーションの質と在室日数は改善しても、不安・抑うつ・PTSDはほとんど減らせないという結論に収束しています。陽性だったのは既存の医療チームが直接行った介入で、新設の専任役職に担わせた介入は陰性に傾いています。3ステップ支援で対照群と最も差が開いたのは、亡くなった後の面談でした。家族カンファや病室訪問は対照群でもおよそ3分の2で行われていたからです [Kentish-Barnes Lancet2022]。

一方、お悔やみの手紙は、同じ研究グループのRCTでPTSD・不安・うつの症状をむしろ増やしました。手を抜くなら手紙ではなく電話にします。SCCMの家族中心ケアガイドライン（2024）の17ステートメントで強い推奨は「面会を緩和した方針を既定にする」の1つだけでした [Hwang CCM2025]。

§8 DNARと蘇生の倫理 — 範囲は心停止時だけ、価値の判断は事前に、スローコードは選ばない

DNARは、この資料の中心にある考え方がいちばん試される場面です。DNARの拡大解釈は日本で最も多い誤りの一つで、学会が名指しで警告しています。一方で、「DNARの患者が予期せず心停止したら蘇生するか」という問いでは、現場の意見が今も割れます。割れる原因は、話し合ったかどうかではなく、合意の中身が詰まっていないことにあります。この章の結論は、価値の判断を事前の話し合いで済ませ、ベッドサイドでは迷わない範囲の明確な指示にし、「すべてやってください」には処置に降ろして答え、形だけの蘇生は選ばない、ということです。

詳しくは DNARは原因を問わず範囲を明示して運用する (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/dnar-scope/)

原疾患限定論の限界・入院時の確認・指示の書き方　**まとめ** (https://hiro-oka.github.io/icu-masterclass/dnar-scope/)



DNARで決まるのは、心停止したときにCPRを試みないことだけ。

この章のポイント

1. **DNARの範囲は心停止時のCPRだけ。通常の治療は控えない。部分的DNARとスローコードはしない**
2. **フレイルなどの医学的な見込みは判断の材料で、結論は本人の価値観から出す**
3. **価値の判断は事前に済ませ、原因をその場で問わない範囲の明確な指示にしておく**

8-1. DNARの土台 — 範囲は心停止時だけ、通常の治療は控えない

DNARは心停止時に心肺蘇生（胸骨圧迫・除細動・気管挿管など）を試みない指示で、有効なのは心停止時だけです。酸素・挿管・人工呼吸・昇圧薬・抗菌薬・輸液・栄養・ICU入室を、DNARを理由に自動的に差し控えてはいけません（図6） [JSICM勧告2017] [JJAAM2025]。

DNARで決まっていること

心停止したとき	→	胸骨圧迫・除細動・気管挿管などの蘇生を行わない

DNARでは何も決まっていないこと（別に話し合う）

心停止の前の治療	→	挿管・人工呼吸・昇圧薬・血液浄化・輸血・ICU入室は、目標と価値観に照らして一つずつ決める
症状を和らげる治療	→	抗菌薬・酸素・非侵襲的換気・鎮痛鎮静・補液は、DNARの有無にかかわらず行う

してはいけない運用

一律・便宜的なDNAR	→	入院時の一律設定、業務効率や急変対応の簡略化のための設定
部分的DNAR	→	「胸骨圧迫はするが挿管はしない」のような不完全な蘇生
スローコード	→	意図して不完全に行う形だけの蘇生

日本集中治療医学会の勧告（2017）、日本救急医学会の用語の統一概念（2025）、4学会GL2026のQ37・Q39、AHA 2025 倫理編に基づく

図6. DNARの範囲 — 決まるのは心停止時の蘇生だけ。

図の読み方 — 上の段だけがDNARの中身です。「心停止」を「急変時」とすり替えないでください [JSICM勧告2017]。真ん中の2段はDNARでは何も決まっていない領域で、いちばん多い誤りはここまで「DNARだからやらない」と読み替えることです。下の赤い段のうち、部分的DNARは不完全な蘇生では救命できないこと、スローコードは患者への危害・尊厳の侵害・家族への欺瞞にあたることが理由です [JSICM勧告2017] [AHA2025 倫理編]。

日本集中治療医学会は2017年の勧告で、図6の真ん中の2段にあたる治療をDNARを理由に自動的に差し控えてはならず、DNARのマニュアルと終末期医療のマニュアルは分けて作ることが強く推奨されるとしました [JSICM勧告2017]。日本救急医学会の用語の統一概念（2025）も、「DNARを取る」という言い方と、DNARを理由に心停止前の挿管や人工呼吸を行わない誤認を名指しで正しています [JJAAM2025]。この誤りは個人の勉強不足より、様式の設計の問題です。22研究を統合したナラティブレビューは、DNAR指示の範囲が紙の上で定義されていない限り、現場の解釈は必ずばらつくと説明しています [Khayat Kakhki ResuscPlus2026]。

8-2. 原疾患限定論に根拠はない ― 「原疾患による心停止だけに適用」という読み方

DNARを原疾患による心停止に限るという読み方は、学会の文書に根拠が見当たらず、日本集中治療医学会の委員会報告は、別の原因（特に医療行為の合併症）で心停止したときの対応を事前に話し合っておくよう求めているだけです [JSICM委員会報告2016]。

この読み方には2つの無理があります。第一に、心停止の原因は多くの場合その場では分かりません。肺炎で酸素を投与されている患者が急に心停止したとき、それが肺炎のためかどうかは判定できず、最初に発見するのはたいてい看護師です。「発見したら原因を問わず蘇生する」なら、それはDNARではなくフルコードです。第二に、医療者がDNARを考える根拠の多くはCPRがその人に利益をもたらさないという見込みで、原因が分からなくてもその見込みは変わりません。本人が自分の価値観から蘇生を拒むことも、別の正当な根拠です [AHA2025 倫理編]。

8-3. フレイルは医学の問いの材料で、価値の問いの結論ではない

フレイルは院内心停止後の死亡や神経学的転帰の悪さと関連し、「蘇生がうまくいくか」という医学の問いの材料になりますが、「この人にとって蘇生が最善か」という価値の問いには答えません（表21）。

表21｜フレイルと心停止後の転帰 ― 関連は強いが、一律の線は引けない

研究	結果
系統的レビュー（7研究1,704例）	フレイルでCPR後の死亡 OR 3.56（死亡率 90.2%対71.6%） [Hamlyn 2022]
60歳超の院内心停止90例	CFS 4超では生存退院0例、非フレイルは26% [Ibitoye]
日本の院外心停止（SOS-KANTO 2017）	発症前のCFSが高いほど30日後の神経学的転帰が悪い [Yamamoto AnnEmergMed2023]

CFSの閾値は研究ごとに異なり（4超、5以上）、小さな後ろ向き研究で「無益」と断定するのは言い過ぎです [Hamlyn 2022]。委員会報告も、後期高齢やADLの低さだけでは終末期とはいえず、それを理由にCPRを差し控えることが正当とはいえないとして、適応がずるずる広がることを警戒しています [JSICM委員会報告2016]。

AHA 2025も、年齢を生命維持治療を制限する唯一の決定因子にしないとし、利益がないという判断には価値観が入りうるので、それを引き出す方法としてSDMを置いています [AHA2025 倫理編]。4学会合同ガイドラインは、入院時に一律に設定するDNARを否定し、DNARは適用範囲が明確であることが不可欠だとしています。フレイルからの予後の見積もりは、4観点のうち「医学的側面」の一つにすぎません。

旧ガイドラインの終末期の例示が「線」として読まれ、その外側で考えが止まってしまったことを、作成側は説明文で認めています [4学会GL2026]。「DNARは原疾患の心停止に限る」という読み方も、単一の線で判断を止めるという同じ構造の誤りです。

8-4. 看護師と医師の役割 — 価値の判断は事前に、ベッドサイドでは指示に従う

価値の判断はベッドサイドではなく事前の話し合いの場で済ませ、その結果を範囲の明確な指示にしておけば、心停止を発見した看護師はその場で本人の価値観に立ち返る必要はありません。指示の範囲が曖昧で迷ったときは、蘇生を始めながら確認します [AHA2025 倫理編]。

医師の側は、§6の順で価値観を聴いてから、表8の強さ（§3-2）を選んで方針を推奨します。強い形を使う前に家族が決定を委ねたいかを確かめる点も§3-3のとおりで、言い方の対比は§3-1の例をそのまま使えます [Curtis JAMA2020] [AHA2025 倫理編]。

8-5. 窒息と医原性の心停止 — 原因ではなく、事前に合意した範囲で決める

気道が詰まって苦しんでいる段階での異物除去や吸引はCPRではないのでDNARと無関係に行い、窒息で心停止した後にCPRをするかどうかは、原因ではなく事前に合意した範囲で決まります。

例外として事前に検討しておくのは、処置に伴う可逆的な医原性心停止です。原因が分かり可逆性が高く、処置に同意した時点で合併症からの回復は本人のゴールに含まれていると考えられます。日本集中治療医学会の調査では、DNARのある80歳の心不全患者が内視鏡中の喉頭痙攣で心停止した場面で、医師の83.4%が「CPRをする」と答えました [JSICM委員会報告2016]。ただし医原性なら自動的に蘇生するのではなく、処置中にDNARを一時的に変更・解除するかを事前に決めておきます。

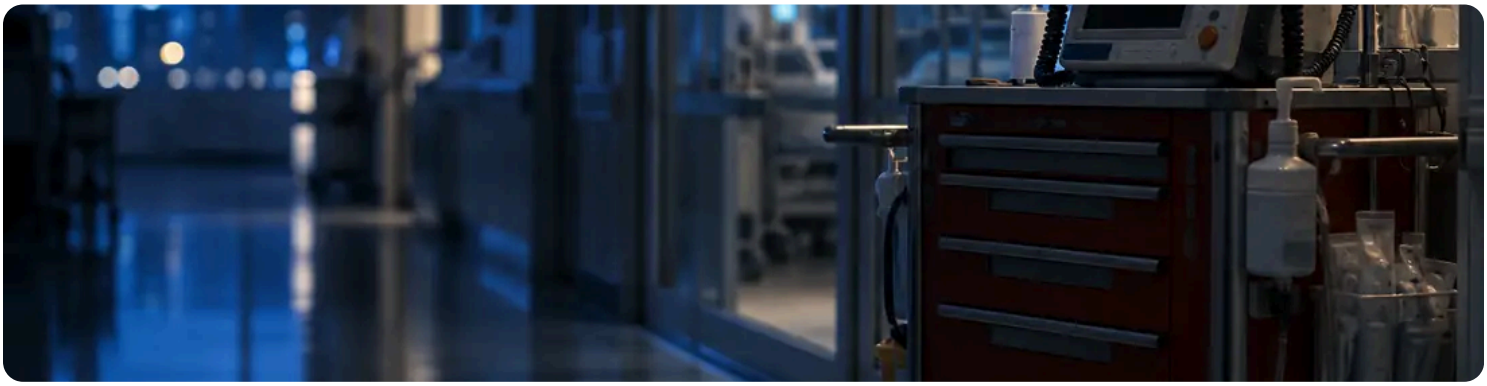
DNARの指示の書き方 — 一般論としての実装の一案（ガイドラインのルールではない）

1. 心停止時は原因を問わずCPRを行わない（発見者にその場で原因を判断させないため）
2. 窒息による心停止も含む（DNARを考える患者では十分に起こりうるため）
3. 処置に伴う医原性心停止は、処置中にDNARを一時的に変更・解除するかを事前に決める
4. 蘇生を始めた後に本人の望む状態に戻れないと分かれば、速やかに終了を検討する

4学会合同ガイドラインが求めているのは「適用範囲を明確にする」ところまでです。「原因を問わず」は、原因をその場で推定できない現場でそれをどう実装するかの提案で、施設ごとに倫理委員会などで検討して決めるものです。文例は§15-1にあります。

8-6. 「すべてやってください」への答え — 処置に降ろして答え、スローコードは選ばない

形だけの蘇生（スローコード）は、米国の倫理文献34本の系統的レビューで82.4%（28本）が欺瞞、67.6%が患者への潜在的な害を理由に反対され、61.8%（21本）が医師は無益なCPRを断ってよいとしており、残る選択肢は「目標を共有した全力の蘇生」か「無益の方針に基づく蘇生の辞退」です [Fontenot CCM2026]。



「すべてやってください」には、処置に降ろして心停止の前に答える。形だけの蘇生は選ばない。

賛成側の論拠は家族の情緒的な必要に立脚しており、その慰めは家族が真実を知らないことに依存しています。併走するエディトリアルは、真の問題は個々の医療者ではなく、欺瞞を最良の選択肢にしてしまう法と方針の側にあると指摘しました [Ajzenberg CCM2026]。「すべて」の中身を、胸骨圧迫・気管挿管・電気ショック・昇圧薬・透析のように一つずつの処置に降ろし、心停止が起きる前に本人の価値観に照らして話します。4学会GLも、適切なプロセスで終了・差し控えを選んだ後に苦痛を伴う心停止時の蘇生を行うことは推奨しないとしています（Q38） [4学会GL2026]。

× 包括的に聞く

「すべてやりますか」

○ 処置に降ろして、心停止の前に話す

「胸骨圧迫・挿管・電気ショックは、この方の目標の役に立つでしょうか」

生理学的に無益なCPRをプロトコルどおり始めて短時間で打ち切る time-limited code も、誠実さを満たさず、害も減らさず、家族の要求のために患者への義務を押しのけるため、倫理的な戦略にならないと論証されました [Wasserman CritCare2026]。肋骨・胸骨骨折の多くは最初の1分以内に起こり、リスクは前半に集中します。TLTの枠組みが正当なのは本当に不確実なときだけで、無益なCPRへの要求に流用しません。ただしこれはデータではなく倫理的論証です [Wasserman CritCare2026]。

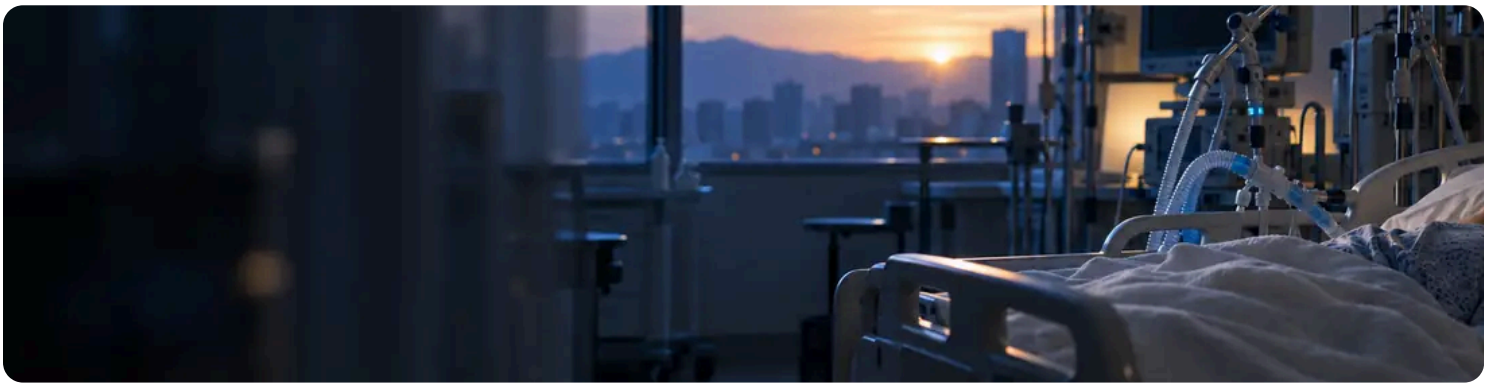
8-7. 蘇生の倫理的問題は、個人ではなくシステムの産物

蘇生をめぐる倫理的問題の大半は、個人の道徳的欠陥ではなく、法的曖昧さ・組織文化・階層・資源制約が生む構造的な産物で、日本でも「DNAR＝心停止時のみ」の拡大解釈が記述されています [Khayat Kakhki ResuscPlus2026]。

医師へのコーチングを行ったCODE試験では、過剰治療の可能性がある患者での書面のDNI-DNACPR決定が29.7%対19.6%に増えましたが、チームの倫理的風土（EDMCQ）の差は0.02点で動きませんでした [CODE ICM2024]。書式を整えるだけでは風土は変わりません。組織として何を先に変えるかは§12で扱います。

§9 差し控え・終了・TLT — 同じ問いへの答えから選び、一つずつ決め、過程を記録する

§5の手順を踏んで終了・差し控えが妥当と判断されたら、選べる対応は差し控え・終了・期限付きの試行（TLT）の3つです。どれを選んでも症状緩和は続き、心停止時の蘇生は行いません。この章の結論は、始めたかどうかで倫理は変わらないから迷えばTLTで始めて期日に立ち止まり、個々の治療は何のために使っているかで一つずつ決め、考慮した時期の根拠と検討に加わった全員を記録する、ということです。



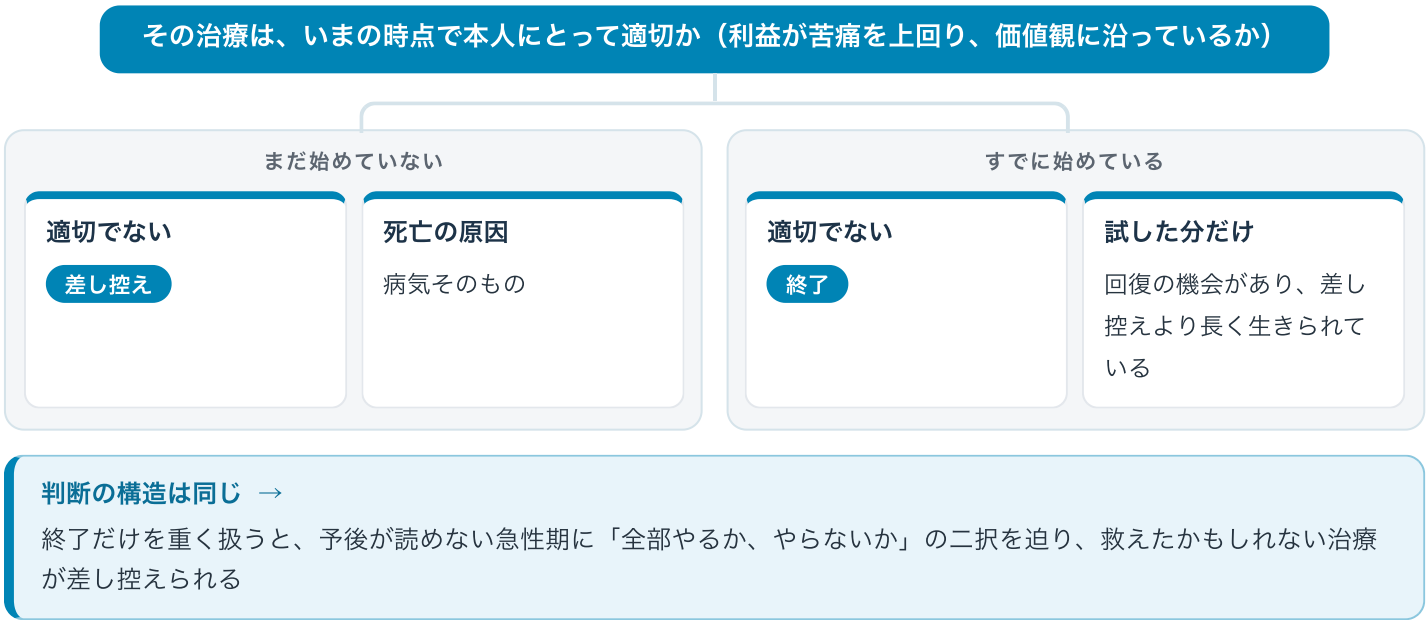
TLTは目標と再評価の日を決めてから始める。期限で自動的に終了も延長もしない。

この章のポイント

1. **始めたかどうかで倫理は変わらないと知る。「やめられないから始めない」をしない**
2. **迷えばTLTにし、目標・期日・価値観との結びつきを先に書く**
3. **抗菌薬・人工栄養・ペースメーカーも目的で一つずつ決め、記録は3区分で残す**

9-1. 差し控えと終了は倫理的に同等 — だから迷ったら始めて試せる

治療の倫理的な評価は始めるか終えるかの順序ではなく「その時点で本人にとって適切か」で決まり、死亡の直接の原因は病気であって治療の終了ではありません。未開始なら差し控え、開始済みなら終了を考えるという判断の構造は同じです（図7） [4学会GL2026 Q33]。



4学会GL2026のQ33・Q34と緩和ケア別編の説明をもとに作図

図7. 差し控えと終了は同じ問いへの答え — 始めたかどうかで倫理は変わらない。

図の読み方 — 上の問いは1つで、左右は治療をすでに始めているかどうかの違いだけです [4学会GL2026 Q33]。一度始めた治療はやめられるので（Q34）、予後が読めないときは始めて試し、期限で見直すことができます（9-3）。

「差し控えは許されても終了は許されない」とすると、家族は予後が読めない急性期に「全部やるか、やらないか」を迫られ、救命できたかもしれない患者の初期治療までためらわれます（§1-2）。ただし、記録では両者を項目ごとに書き分けます。倫理的には同等でも、臨床経過はまったく違うからです（差し控え後と終了後の数字は§1-1の表2） [Ethicus-2 JAMA2019]。

ACP（事前の対話）とTLT（始めて確かめる仕組み）は車の両輪です。TLTがあれば「フルコードか、何もしないか」の二択から抜け出せますが、「迷ったらとりあえず始める」の免罪符にはなりません。TLTの主な対象は、心停止時のCPRそのものより、蘇生後の人工呼吸などの生命維持治療です（組み立ては9-3） [4学会GL2026]。

9-2. 3つの対応で、行うことと行わないことを分けて決める

差し控えは新たな治療の開始や増強をせず、終了は症状緩和だけにするか一部を終了・減弱し、TLTは期間を決めて試し、差し控えと終了ではいずれも心停止時の蘇生を行いません（表22） [4学会GL2026]。

表22｜3つの対応 — どれを選んでも症状緩和は最大限続ける

対応	行うこと	行わないこと
差し控え（不開始を含む）	症状緩和の治療とケア。生命維持装置の設定や昇圧薬は減弱できればする	新たな治療の開始と増強。検査・モニターも侵襲なので最小限に。心停止時の蘇生
終了：症状緩和だけにする	鎮痛・鎮静薬を続けて調整する	人工呼吸器・補助循環・除細動機能は停止か取り外しを検討。血液浄化・昇圧薬・血液製剤・抗菌薬・輸液・人工栄養の終了も検討。心停止時の蘇生
終了：一部を終了・減弱する	項目ごとに続けるか、減らすか、終えるかを決める	心停止時の蘇生
期限付きの試行（TLT）	合意した期間、特定の治療を試し、目標に向かって改善するかを確かめる	期限が来たら自動的に終了すること

4学会GLの作成過程で最も議論が集まったのは「一部を終了または減弱する」（コメント34件）とTLT（31件）でした。現場で判断が最も割れる部分です [4学会GL2026 付録2]。

9-3. TLTは目標・期日・価値観との結びつきを先に書き、期日で必ず立ち止まる

TLTは家族とチームの意見が違うときや予後が読めないときに、目標と期間を合意して治療を試す方法で、始める前に「何を目標に試すか」「いつ何で再評価するか」「その結果が本人の価値観とどう結びつくか」を決め、期限で自動終了も自動延長もしません（図8） [4学会GL2026 Q35]。

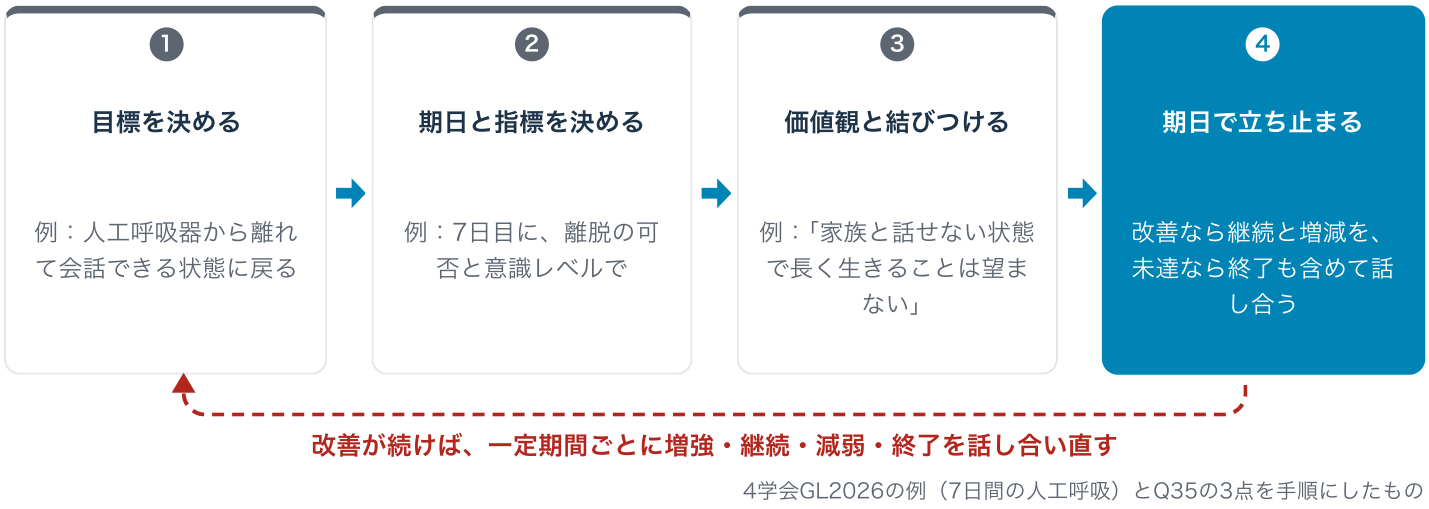


図8. TLTの組み立て — 先に3点を書き、期日で必ず立ち止まる。

> **図の読み方** — 左の3段は始める前に書くこと、右端が期日の判断です [4学会GL2026 Q35]。下の破線は改善したときに話し合いを繰り返す道で、期限が来ても自動的に終了はしません（Q36・Q78）。

TLTは終了へ誘導する枠組みではありません。面談では、Quillらの5要素（臨床問題と予後の定義・本人の目標と優先順位・改善と悪化の客観的指標・再評価の時間枠・終了時に取りうる行動）を明示して合意し、フォローアップ面談をその場で予約します [Quill JAMA2011]。TLTは予後の見通しと、家族が状況を受け入れる時間をもたらす一方、侵襲的な治療の期間が延び「死のプロセスの質」を損なう欠点もあります [4学会GL2026]。

！注意 — 「決めきれないから続ける」にしない

3点が曖昧なまま続けると「決めきれないから続ける」「説明が難しいから先送りする」に陥り、ガイドラインの趣旨に反します。多職種で検討したこと自体は結論の正しさを保証せず、判断が本人の価値観とどう整合するかを説明できることが大切です [4学会GL2026 Q35]。TLTの利益とリスクの実証的なエビデンスは乏しく、Quillら自身も「良い実践の提案」と位置づけています [Quill JAMA2011]。

予後が読めない症例では、TLTを特別な場面の道具にせず、初回の面談から「こういう経過なら、こう見直しましょう」と標準の選択肢として先に示しておくと、後の再評価がゼロからの交渉になりません [Ashana ICM2026]。ガイドラインは、ACPの内容が実際の状況と食い違っても、本人の価値観をもとに意思を推定してよいとしています [4学会GL2026]。

9-4. 抗菌薬・人工栄養・ペースメーカーも、何のために使っているかで一つずつ決める

症状緩和に使っている強心薬は必ずしも減らさず、人工栄養やペースメーカーも生命維持治療になりうるものとして同じ手順で判断し、終末期の抗菌薬は感染部位ごとに症状緩和になっているかで決めます（表23） [4学会GL2026] [Correia ICM2026]。

表23｜個別の治療の考え方 — 一律に止めず、目的で決める

治療	考え方
心不全の苦痛緩和に使っていた強心薬	症状の強さと必要性で増減する。必ずしも減量・終了は要らない（Q40）
ペースメーカー・ICD	依存していれば事実上の生命維持治療。ICDの除細動機能は循環器内科医と相談して停止を検討（Q41・別編）
人工栄養	胃ろうを含め生命維持治療の一つ。行わない場合も口腔ケア・食事介助・苦痛緩和は続ける（Q44）
終末期の抗菌薬	死亡直前の40〜80%に投与されているが、症状緩和は21.4〜56.7%と一貫しない。尿路感染は60〜92%、呼吸器感染は0〜53%と部位で桁が違う
機械的補助循環	対象に含まれ、同じ手順で決める。日本では経験施設が非常に少ない（§10-5）

抗菌薬を始めるなら、開始時に「48〜72時間後に経過・培養・予後で再評価し、改善がなければやめる」と書きます。「もう1コース」が本人の症状ではなく医療者と家族の不安を治療しているなら、それは適応外の投与です [Correia ICM2026]。

9-5. 記録は3区分で — 「考慮した時期の根拠」と「検討に加わった全員」を残す

4学会GLは、医学的な検討とその説明、患者の意思、終了・差し控えを検討する際の対応、の3区分で記録することを求め、説明の対象と内容・理解・同席者、本人の意思と推定意思の根拠、考慮する時期であることの根拠、検討に加わったすべてのメンバーを診療記録に残すよう求めています（表24） [4学会GL2026]。

表24｜診療記録に書く項目 — のちの検証に耐える書き方

区分	記載する事項
医学的な検討とその説明	説明の対象となる本人・家族等とその範囲／説明した内容／理解や受容の状況／同席した医療・ケア従事者
本人の意思	本人の意思、またはACPの記録に示された意思と、それが述べられた状況／それがなければ家族等による推定意思とその根拠
終了・差し控えを検討する際の対応	本人の意思またはACPの内容／推定意思とその根拠／家族等の意向／考慮する時期であることとその根拠／最善のゴールの検討内容／検討に加わったすべてのメンバー

抜けやすい記録

1. 終了・差し控えを考慮する時期であることと、その根拠
2. 家族等による推定意思と、その根拠
3. 説明に同席した医療・ケア従事者と、検討に加わったすべてのメンバー
4. TLTの目標・再評価日・判断の指標
5. DNARの適用範囲

学会の調査では、DNAR指示そのものの記録は9割にあったのに対し、協議の過程の記録は7割にとどまりました [JSICM委員会報告2016]。範囲と根拠が書かれていなければ、夜勤の看護師には伝わりません。意思は変わりうるので、話し合いはそのたびに記録します [4学会GL2026]。コピーして使える文例は§15にあります。

§10 緩和的抜管 — 準備を済ませ、苦痛に先回りし、そばにいる

終了で最も多いのは人工呼吸器の終了です。4学会GLの緩和ケア別編は、止めるもの、抜管の方法、抜管の前後の薬と量まで示しました。この章の結論は、緩和ケアは終了の前から始まっており、抜管の前日から止めるものと時刻を逆算し、薬はボーラスで上限なく効かせ、苦痛が落ち着くまでそばを離れない、ということです。



準備を済ませ、苦痛に先回りし、落ち着くまでそばを離れない。

この章のポイント

1. **経管栄養は24時間前、筋弛緩薬は2時間前に止める**
2. **オピオイドはボーラスで、上限を設けずに使う**
3. **苦痛が落ち着くまで、医師と看護師はベッドサイドを離れない**

10-1. 緩和ケアは終了の前から — 予後ではなく必要性で始める

緩和ケアは予後ではなく必要性に基づくもので、主治医と担当看護師が行う基本的緩和ケア（症状緩和・意思決定支援・心理社会的支援）を救急搬送やICU入室の早期から提供し、終了の後に導入するのでは遅すぎます [Edwards ICM2016] [4学会GL2026]。

救命治療と苦痛の軽減は対立するものではなく両輪です（Q57・Q58）。担い手はICUの臨床医全員で、専門の緩和ケアチームは緩和しにくい苦痛や意思決定の困難があるときの上乗せです [Edwards ICM2016]。敗血症の診療ガイドラインも、GOCの話し合いやTLT、緩和ケアを良い実践として初めて明記し、治療の目標が相によって変わることを示しました [Kesecioglu ICM2026]。

× 危険 — 準備なしに終了しない

侵襲的な治療を終えても症状緩和の治療は最大限続くため、適切な緩和ケアを提供できない状態で生命維持治療の終了・差し控えを行うべきではありません [4学会GL2026]。

10-2. 抜管の前日から、止めるものと時刻を逆算する

経管栄養は24時間前まで、筋弛緩薬は2時間前まで（多臓器不全では18時間前まで）に止めるのが望ましく、透析・昇圧薬・抗菌薬・輸血・身体拘束は終了し、ラインやモニターや検査は苦痛と利益を比べて一つずつ決めます（図9・表25） [4学会GL2026 別編]。

24時間前	12時間前	2時間前	30分前	直前	抜管後
経管栄養を止める 24時間前までに終えておくのが望ましい	**上気道浮腫のハイリスクなら** メチルプレドニゾロン20 mgを4時間おき	**筋弛緩薬を止める** 多臓器不全では18時間前	**分泌物が予想されるなら** ブチルスコポラミン10〜20 mg皮下注	**苦痛を先回り** オピオイドと鎮静薬の事前投与を検討（表26）	**離れない** 苦痛が落ち着くまで医師・看護師がそばで調整

4学会GL2026 緩和ケア別編の本文と薬の表から時刻のある項目を並べたもの。12時間前・30分前・直前の投与は必要な患者に

図9. 抜管までの準備 — 前日から時刻を逆算する。

図の読み方 — 左から右へ時間が進みます。経管栄養と筋弛緩薬の終了、抜管後にそばにいることは全員に、12時間前・30分前・直前の投与は上気道浮腫・分泌物・苦痛の出方を予想して患者ごとに検討します [4学会GL2026 別編]。筋弛緩薬が残っていると苦痛を評価できず、鎮痛を調整できません。

表25｜止めるものと、止めるかを検討するもの — 観るのは数値ではなく、表情と家族の反応

区分	項目	注意点
終了する	透析、経管栄養、昇圧薬、抗菌薬、輸血、筋弛緩薬、身体拘束	家族等と十分に話して決める
終了を検討する（装置）	機械的循環補助、ペースメーカー、ICDの除細動機能	ICDは循環器内科医と相談して除細動機能を停止
終了を検討する（ライン・モニター）	中心静脈・動脈ライン、心電図モニター、パルスオキシメーター	末梢がなければ中心静脈は投与路に残してよい。モニターは外してもよく、付けるならアラームを切る。外させないための身体拘束はしない
終了を検討する（ケア・検査）	バイタル測定、輸液、体位変換、血液検査、X線・CT	輸液は浮腫・胸水・せん妄につながる。家族に分かりやすく説明する

実施の前には、十分な話し合いで決めたこと、ゴールが症状緩和優先であること、心停止時に蘇生しないこと、抜管後に再挿管しないことを医療者の間で再確認します [4学会GL2026 別編]。モニターを外すか残すかは、一律にせず家族に選んでもらうのが安全です。消したことで最期の喘ぎに驚いた家族と、消してもらえずモニターを見て崩れた家族が、同じ研究の中に並んでいました [Kentish-Barnes ICM2026]。

10-3. 抜管は段階的離脱か即時抜管 — 死亡までは数分から数日と伝える

高度の呼吸サポートが要る呼吸不全では15〜30分かけて設定を下げる段階的離脱、意識障害の患者では準備のうえ設定を下げずに抜管する即時抜管が多く選ばれ、抜管から死亡までの中央値は0.9時間（海外の報告）ですが数時間〜数日の例もあります [4学会GL2026 別編]。

段階的離脱（gradual weaning）

- 15〜30分かけて設定を下げ、できるだけ自発呼吸へ移す
- 麻薬・鎮痛薬を適量投与しながら行い、その後に抜管する
- 高度のサポートが要る呼吸不全で多い

即時抜管（immediate extubation）

- 設定を下げずに抜管する
- 鎮静・鎮痛の準備を済ませてから行う
- 脳神経疾患などの意識障害で多い

家族には不確実さを持たせて説明し、状態が変わるたびに伝えます。死戦期呼吸・死後の筋の攣縮・「思ったより長くかかること」を先に言葉にしておくと、死の徴候を読み取れない苦しさを減らせます [Kentish-Barnes ICM2026]。浮腫・外傷・腫瘍で気道閉塞のリスクが高ければ、人工呼吸は終えても気管チューブは残す選択肢があります [4学会GL2026 別編]。

10-4. 薬はボーラスで効かせ、オピオイドに上限を設けない

呼吸困難と痛みにはオピオイドが最も有効とされ、効果が早く蓄積しにくい「ボーラス・ファースト」で、オピオイド未投与ならモルヒネ2〜5 mgから始め、効果がある限り症状が緩和されるまで増やし、用量の上限は設けません（表26） [4学会GL2026 別編]。

表26｜抜管の前後の薬の目安 — 持続投与中なら、直近の量を基準に上乗せ

場面	モルヒネ	フェンタニル	ミダゾラム
未投与の初回	2〜5 mg 静注・皮下。高齢・衰弱ではさらに少なく	20〜50 μg。安全域が狭いので少量ずつ	0.01〜0.06 mg/kgを1分以上かけて
持続中の抜管直前	直近の効果量の2倍をボーラス	直近1時間量の25〜50%をボーラス	持続の1時間量をボーラス
持続なしの抜管直前（例）	5分前に5 mg	5分前に25〜100 μg	5分前に2〜4 mg
抜管後に苦しそうなとき	10〜15分ごとに追加	5〜10分ごとに追加	5〜10分ごとに追加
頻回にボーラスが要るとき	持続中なら速度を25〜50%増やす。持続していなければ持続を始める（効いたボーラス量の半分の時間量から。例：モルヒネ2 mgで緩和したら1 mg/時）		

表は一例で、体重・年齢・病状・臓器障害で調整します。緩和ケア別編の薬の表は米国救急医学レジデント協会の実務記事を改変したもので、日本の用量の根拠ではありません。全量・その他の症状の薬は解説ページの§5と原典「4学会合同ガイドライン（2026）緩和ケア別編」の表1・表2で確認してください [4学会GL2026 別編]。

鎮静薬は本来、症状緩和薬を使っても抑えられないときだけ使うものですが、ベンゾジアゼピンは不安やせん妄の症状緩和薬でもあるため、実際には最初から併用されることが多いとされます。予想に反して長く生存し状態が安定したら減量も含めて調整し、死亡まで機械的に鎮静を続けません [4学会GL2026 別編]。

10のガイドライン・コンセンサス声明を統合した系統的レビューも、質の高いエビデンスがないにもかかわらず、定量的な疼痛評価、疼痛にはオピオイド・不安にはベンゾジアゼピン、終了時に筋弛緩薬を残さない、上限用量を設けない、の点で推奨が一致していました（表27） [Durán-Crane CCM2019]。症状管理のための増量という意図は、滴定のたびの記録で示します。これが症状緩和と死期の短縮を分ける境界線です。

表27｜終末期の疼痛管理で10文献が一致した5点 — 根拠は統計より倫理と合意

一致点	内容
疼痛評価	行動観察スケールを含む定量ツールで継続的に評価する
薬の選択	疼痛には麻薬性鎮痛薬、不安にはベンゾジアゼピン
筋弛緩薬	終了時に効果を残さない。苦しんでいても外から分からなくなる
用量の上限	望む効果か耐えがたい副作用が出るまで増量する。最大用量は設けない
質の指標	定量評価スケールを終末期の疼痛管理の質の指標に使う

10-5. 症状ごとの初手 — 分泌物は浅く吸い、不安をオピオイドで眠らせない

不安にはミダゾラム、過活動型せん妄には抗精神病薬、気道分泌物には体位の工夫と輸液の減量、上気道狭窄には抜管前のカフリークテストが別編の初手で、不安やせん妄に鎮静目的でオピオイドを使うことは推奨されません（図10） [4学会GL2026 別編]。

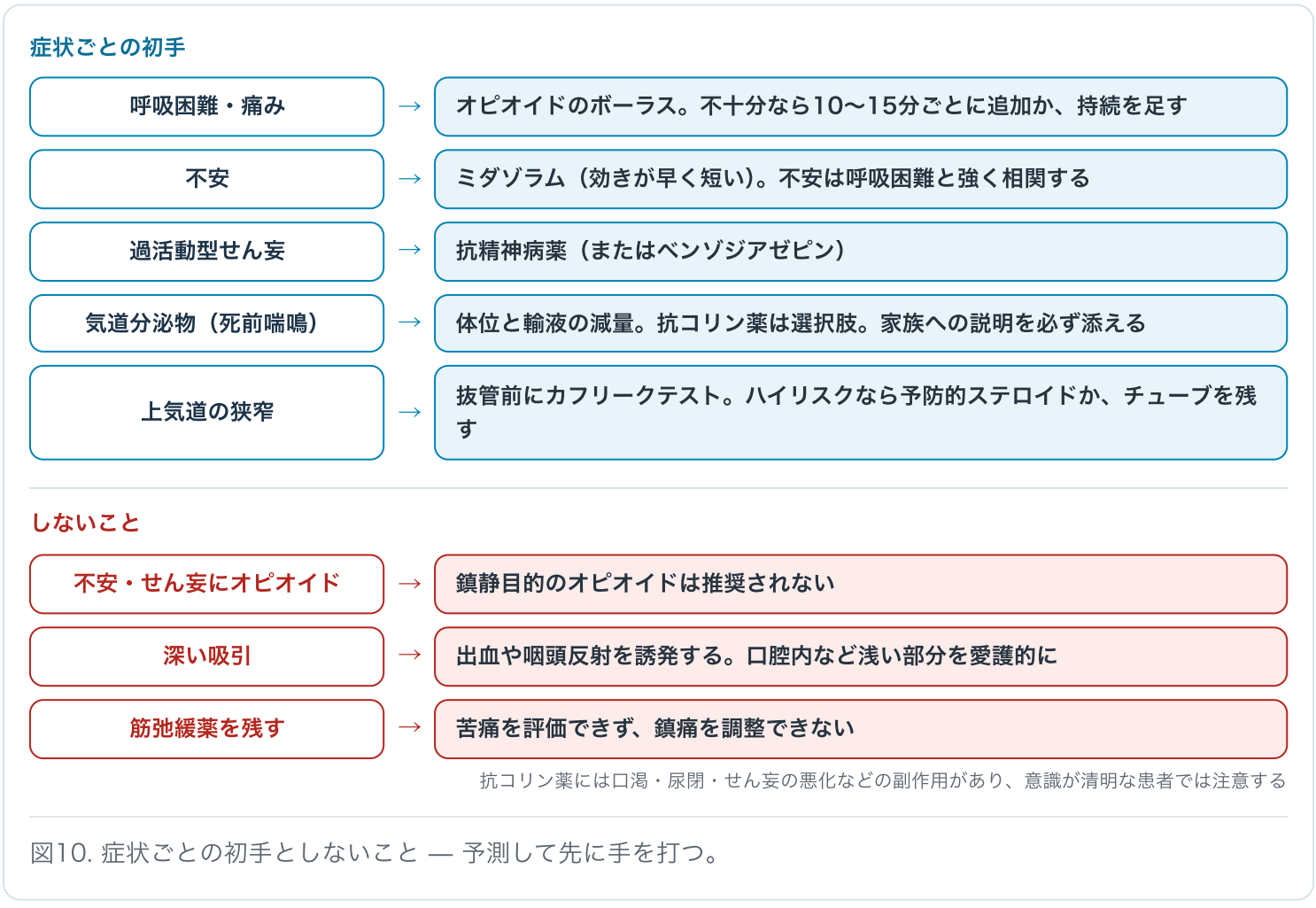


図10. 症状ごとの初手としないこと — 予測して先に手を打つ。

> **図の読み方** — 上の5段が症状ごとの最初の一手、下の赤い3段がしないことです [4学会GL2026 別編]。死前喘鳴は本人の苦痛ではないとする見解もありますが、そばにいる家族の苦痛になることが多く、説明そのものが初手の一部です。意思表示できない患者の呼吸困難は、日本語版RDOS（心拍数・呼吸回数・落ち着きのなさ・奇異呼吸・補助呼吸筋・呻吟・鼻翼呼吸・苦悶表情の8項目）を補助に、表情・仕草・家族の評価を加えて判断します。

ECMOなどの機械的補助循環の終了は、日本では経験施設が非常に少なく、実際にはIMPELLAやLVADの血栓閉塞、ECMOの人工肺の機能低下が終了の条件になっています。別編はTLTを当てはめ、期間内にゴールを達成できないと考えられたときに終了を検討するよう勧めています [4学会GL2026 別編]。

ECMOの看取りを、準備・薬のタイミング・機器操作のばらつきが苦痛を生む「低頻度・高リスクの手技」として、4相モデルとチェックリストで標準化する提案もあります（実証データはなく専門家意見） [Hubel Healthcare2026]。この提案の要点は、VA-ECMOでは流量を下げる前に苦痛緩和薬を入れること（流量0では薬が回らない）と、VV-ECMOでは血流を保ったままスイープを段階的に0へ下げることです。VV-ECMOの管理はVV-ECMO 実戦管理ガイドで扱います。

§11 看取り・死別・死の判定・臓器提供 — 家族の時間を守り、告知と依頼を分ける

終了を決めた後から死別の後まで、家族のケアは続き、倫理の問いも続きます。死をどう判定し、どう伝えるか。臓器提供の可能性を、終了の判断とどう切り離すか。この章の結論は、家族のケアを6つの時期で考え、死亡確認と脳死の説明は「判断した」と言い、治療終了の決定を先にして臓器提供の話は後に分ける、ということです。



家族のケアは、決める前から亡くなった後まで続く。

この章のポイント

1. **家族のケアは話し合いの前から死別後まで6つの時期で考える**
2. **死亡確認で確かめているのは「もう戻さない」という決定（permanence）。脳死は「臓器を支える治療」と言い換える**
3. **終了の判断が先、臓器提供の提示は後。告知と依頼を同じ面談に入れない**

11-1. 家族のケアは6つの時期で — 亡くなった後の面談まで含める

ICUや救急外来での死別は悲嘆を長引かせるリスクが高いため、4学会GLの緩和ケア別編は家族のケアを、話し合いの前・間・後、終了前、臨終時、死別後の6つの時期に分けて示しています（図11） [4学会GL2026 別編]。

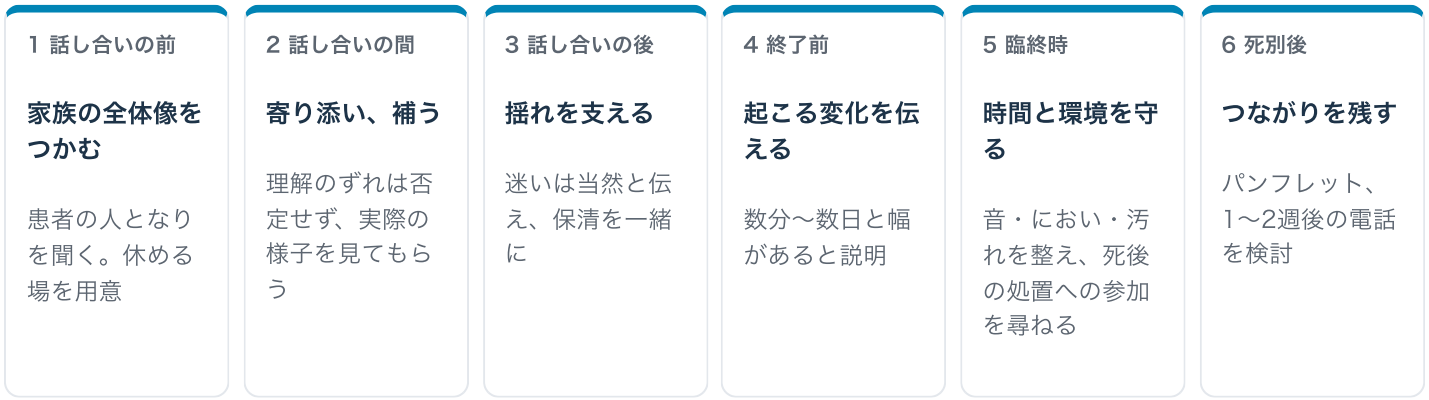


図11. 家族のケアの6つの時期 — 決める前から、亡くなった後まで。

図の読み方 — 左から時間が進みます [4学会GL2026 別編]。右端の死別後の関わりは、3ステップ支援で対照群と最も差が開いた部分（死後の面談 29% vs 85%）にあたります（§7-7） [Kentish-Barnes Lancet2022]。

表28｜残された時間のケアの例 — その人らしさと、家族とのつながりを支える

種類	例（4学会GL2026 緩和ケア別編）
本人を尊重するケア	好きな衣服・帽子・枕、好きな音楽やアロマ、入浴・洗髪・マッサージ、思い出の写真、誕生日や記念日のお祝い、好きな飲み物を味わう、口腔ケアと保湿
家族とのつながり	面会のルールを柔軟に、電話やビデオ通話、家族への手紙づくりの支援、保清への家族の参加（顔への送風で呼吸困難が和らぐことがあると伝え、家族から風を送ってもらう）
死後を見すえたケア	希望があれば集合写真、手形や髪の一部を形見に、遺言・葬儀などの気がかりを専門家へつなぐ

立ち会いを望まない家族には一度退室してもらい、苦痛が抑えられたのを確かめてから入室してもらいます [4学会GL2026 別編]。遺体との対面は独立した場面として扱い、準備の説明と付き添いを置きます。冷たさ・硬さ・においが記憶に残り続けると語られています [Kentish-Barnes ICM2026]。面会のルールは希望に応じて柔軟にします（§7-7）。人間的なケア全般はICUの人間的ケア、生存者と家族の退室後はPICSとICU退室後のフォローで扱います。

11-2. 死亡確認は permanence — 確かめているのは「もう戻さない」という決定

蘇生を止めて死亡を確認するとき、確かめているのはどんな手段でも戻せないこと（irreversibility）ではなく、循環を回復させないという私たちの決定に支えられた永続性（permanence）で、死の判定は基準の機械的な適用ではなく臨床判断です（表29） [Le Dorze CritCare2026]。

表29｜死の判定を読むための言葉 — 2つの「戻らない」を区別する

用語	意味	例
permanent（永続的）	自然には再開せず、介入によっても回復させないと決めた機能停止	蘇生を止めた心停止患者の脳機能
irreversible（不可逆的）	利用可能なあらゆる手段でも回復させられない機能停止	心停止中の脳機能は直接観察できず、この閾値は同定できない
performative（遂行的）	発話そのものが現実をつくる行為	「死亡を確認しました」という宣告が、患者を医学的・法的・社会的に死者へ変える
no-touch時間	循環停止の確認後、自己心拍再開が起きないことを確かめる待機時間	長さは法域で異なる

これは基準を緩める話ではなく、基準の適用の仕方を言語化する話です。脳死の説明では「検査で証明されました」ではなく「複数の所見を突き合わせて判断しました」と言います。補助検査が見ているのは脳灌流や電気活動という代替の指標で、心臓が拍動し皮膚が温かいままの体を前にした家族には、神経学的基準による死は直感に反しうるからです [Le Dorze CritCare2026]。死亡確認での無呼吸・無循環の観察時間は手順書に明記し、暗黙知にしません。

11-3. 臓器提供は、治療終了の決定の後に独立した話として — 告知と依頼を分ける

臓器提供の可能性が終了の判断に影響してはならず、方針が整理された後に独立したプロセスとして提示し、死亡告知と提供の依頼を同じ面談枠に続けて入れないこと（decoupling）が家族を守ります [4学会GL2026 Q79] [Choi CritCare2026]。

4学会GLは、脳死とされうる状態での脳死下臓器提供は終了・差し控えの意思決定と切り離せないので同じ多職種検討とSDMの手順で話し合い、心停止後臓器提供は終了・差し控えの意思決定が示された後に専門家の慎重な判断のもとで検討するとしています。提示しないことも、情報に基づいて決める機会を損ないます [4学会GL2026]。28本の質的研究の統合は、脳死後提供と心停止後提供では家族の苦悩の質が違うことを示しました（表30） [Choi CritCare2026]。

表30｜脳死後提供（DBD）と心停止後提供（DCD）の家族の体験 — 同じ「提供」でも経験は別物

次元	DBDの家族	DCDの家族
目にするもの	宣告されたのに生きているように見える体（温かさ・色つや）	死んでいく過程そのもの（治療終了と心機能の停止）
時間の感覚	宙づりの時間。宣告と実感の不協和	時間の圧縮。臓器の時間枠が別れの時間を切り詰める
道徳的な重み	「本当に死んでいる」証拠を求める認知の作業	「死のタイミングに関わった」という決定の残滓

家族を最も傷つけていたのは、臨床医の態度より、告知と依頼を続けて行う手順や、臓器を一つずつ確認させる同意書、書類の山といった制度の設計でした [Choi CritCare2026]。患者を臓器の供給源ではなく一人の人として扱い、話しかけ続けた臨床医が、家族に安心を与えていました。米国の集中治療医のグループは、心停止後提供でも症状緩和の目標・薬剤・用量は変えないと宣言しています（意見論文） [Oppenheim CritCareExplor2026]。

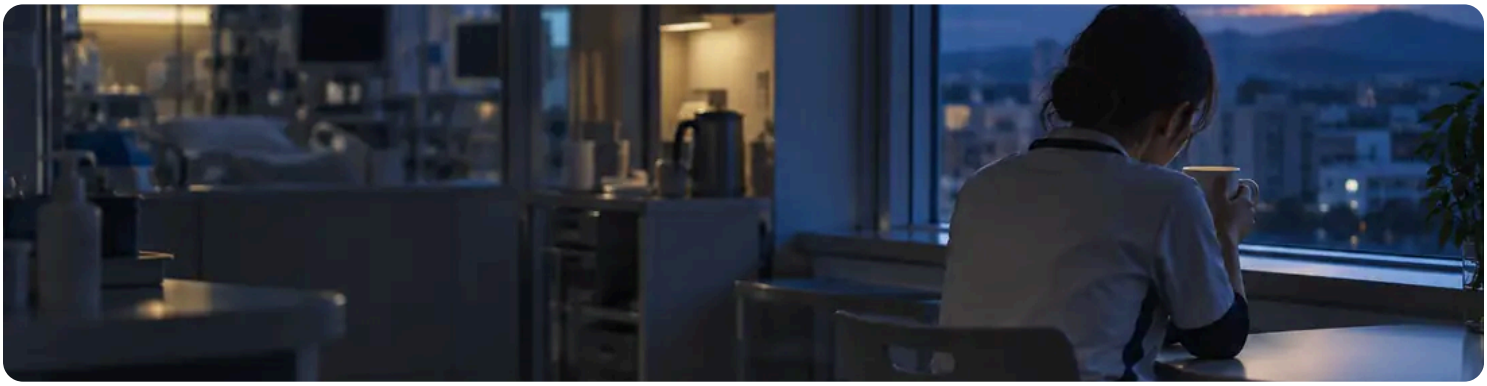
11-4. 脳死を家族に伝える言葉

「生命維持装置」ではなく「臓器を支える治療」、「昏睡」ではなく「回復しない脳の損傷」と言い、判定に立ち会った家族は理解度の満点到達が66%対20%と高く、心理的負担は増えませんでした [Wu JAMA2026]。

複数回の面談を最初から計画すること、判定に関わる医師と臓器提供の担当者を分けることも挙げられています。米国では脳死は法的な死ですが、日本では法的脳死判定は臓器提供を前提とする場合に限って行われます。言葉の選び方の原則は使い、法的な部分は日本の制度で読み替えます [Wu JAMA2026]。

§12 チームを守る — モラルディストレスは個人の耐性ではなく組織の課題

「正しいと思うことができない」苦しさ（モラルディストレス）は、個人の弱さではなく、研修や個人の頑張りでは解決しません。この章の結論は、モラルディストレスを施設の要因から読み、研修やデブリーフィングより先に権限と手続きを変える、ということです。



モラルディストレスは個人の弱さではない。先に変えるのは権限と手続き。

この章のポイント

1. モラルディストレスを施設の要因（文化・階層・手続きの不在）から読む
2. 研修より先に、権限と手続きを変える
3. デブリーフィングは予防ではなく緩和と知る

12-1. 文化・階層・手続きの不在 — モラルディストレスを増やす施設の要因

米国4学術病院の122人の面接は、モラルディストレスを増やす施設の要因として、医療消費主義を受け入れる「ノーと言えない」病院文化、医療の階層（主科と専門科の間も含む）、治療を縮小するための手続きの不在を名指ししました（表31） [Brender JAMANetwOpen2025]。

表31｜モラルディストレスの施設要因 — 個人ではなく組織の問題

増やす要因	和らげる要因
医療消費主義を受け入れる病院文化	階層を越えて臨床医に権限を与える方針（看護師が単独で緩和ケア・倫理コンサルを依頼できる）
医療の階層（主科と専門科のコンサルタントの力関係を含む）	対立の処理と情緒的支援の資源（緩和ケアチーム・death rounds など）
治療を縮小する手続きの不在（「治療を足す手続きはあるのに、減らす手続きがない」）	現場発の改善と支持的な管理職（家族面談への看護師の同席を必須にする など）

モラルディストレスは特に看護師が経験しやすく、同じ場面が来るたびに上乗せされて残ります（moral residue）[4学会GL2026 別編]。複数の医療者が同じ患者に「不適切な治療」と感じているときは、それ自体が予後のシグナルでもあります（§5-4）。同じオランダのコホートでは、不適切なケアを感じることが医療者自身の感情的消耗（調整β 0.4）と離職意向（調整OR 1.6）にも独立して関連し、終末期の決定を先送りする文化が両方を押し上げ、多職種の相互尊重が押し下げていました。看護師の終末期意思決定への形式的な「関与」は多変量では残らず、効くのは声が聞かれる対話の質と決定を先送りしないことだと読めます（横断研究で、介入効果は未検証）[PICNL-ICU ICM2026]。別編は、終了・差し控えに関わる医療者に起こりうる心理的な負担を5つに整理しています（表32）。

表32｜医療者に起こりうる心理的負担（4学会GL2026 緩和ケア別編） — 名前が付くと、組織で扱える

負担	特徴
モラルディストレス	正しいと信じることが他者の価値観や組織の制約で実行できないときの不満・怒り・失望。看護師が経験しやすい
共感疲労	共感がケアの原動力になる一方、甲斐なく死や悪化を繰り返し経験して無力感に陥る
PTSD・急性ストレス症	侵入・覚醒・回避・認知と気分の陰性変化。曝露から1か月以内なら急性ストレス症
二次的外傷性ストレス	心的外傷を直接経験していない支援者が、PTSDと同様の反応を示す
バーンアウト	職場環境・人間関係・過剰な業務が続いて起こる。疲弊→シニシズム→職務効力感の低下

ICU看護師の34研究を統合した系統的レビューでも、上位の要因は無益と感じる延命治療と不要な検査・処置の実施でした（統計処理に疑義があるためプール値は使わない）[Qu BMCNurs2026]。

12-2. 先に変えるのは権限と手続き、デブリーフィングはその次

効いたのは役割の新設ではなく権限と手続きの変更で、デブリーフィングは起きた苦痛を和らげる「緩和」であって「予防」ではないため、順番を逆にしません [Brender JAMANetwOpen2025]。

組織として変える順番

1. 看護師が単独で倫理・緩和ケアコンサルを依頼できる権限を明文化する
2. 家族面談への看護師の同席を、実際の割合を測ってから必須にする
3. 治療の終了条件を説明と同意の段階で書面に残す（TLTの目標・期日）
4. 困難な事例の後に、短いデブリーフィングを定例にする
5. スタッフの心理状態を定期的にスクリーニングする（日本語版MMD-HPなど）

新しい役割を作るなら、その担い手のモラルディストレスも見込みます。看護師ファシリテーターの研究では、部門長の支持の有無、役割の曖昧さ、既存職種との縄張りが実装を阻み、担い手自身が「家族の前で本当に一人」と孤立を語っていました [Renet ICM2024]。4学会GLの緩和ケア別編も、人員配置と仕事量の管理、デブリーフィング、定期的なスクリーニング、外部チームと連携した相談体制を組織的支援として挙げ、MMD-HPなどの日本語版尺度を一覧にしています [4学会GL2026 別編]。書式を整えるだけでは倫理的風土が動かないことは§8-7のCODE試験が示しました。医療者の判断のずれそのものはICUの判断はなぜ外れるかで扱います。

§13 公正・エイブリズム・高齢者 — 年齢や障害で推し量らず、本人に尋ねる

意思決定には、無自覚の前提が入り込みます。「この人は決められない」「この人のQOLはどうせ低い」という思い込みは、4原則の解釈を内側から歪めます。この章の結論は、障害や医療機器の使用だけを理由に差し控え・終了を検討せず、QOLは外見から推し量らず本人に尋ね、高齢者の判断根拠は年齢ではない、ということです。



年齢や障害で推し量らず、本人に尋ねる。

この章のポイント

1. **障害や医療機器の使用だけを理由に、差し控え・終了を検討しない**
2. **QOLは外見から推し量らず、本人に尋ねる**
3. **高齢者の判断根拠は年齢ではない。強い推奨はまだない**

13-1. エイブリズムの3つの問い — 面談とカンファで足して点検する

エイブリズムは差別の意図ではなく無自覚の前提として意思決定に入り込むので（3つの経路は§5-5）、面談とカンファで3つの問いを足して点検します [Taccone ICM2023]。

足す3つの問い

1. 「ご本人が普段使っているコミュニケーション手段は何ですか」（入室初日に）
2. 「入院前のベースラインは、何ができる状態でしたか」
3. 「この推奨は、この方に障害がなかったとしても同じですか」（推奨を書く前に）

中等度〜重度の障害を持つ153人の面接では、54.3%が自分の生活の質を excellent または good と評価しました。一方で45.7%はQOL不良と答え、疼痛・倦怠感・コントロール喪失・生きる目的の欠如が共通していました。障害の重さからQOLを一律に推し量らず、本人に直接尋ねます [Albrecht SocSciMed1999]。

13-2. 根拠にしてはいけないもの — ベッド状況・無益性・予後モデル

4学会合同ガイドラインは、ベッド状況・病院経営・医療資源・収益性・「無益性」を判断根拠とする枠組みを採用せず、障がいの有無や医療機器の使用状況だけを理由に終了・差し控えを検討せず、外見や機能からQOLや価値を推し量らないと明記しました（Q47・Q70〜Q76） [4学会GL2026]。

予後モデルを治療の縮小・終了の根拠にしないこと、予測は共有する情報で決定は価値観と合意で行うことは§5-3のとおりです [Bein ICM2023]。

13-3. 高齢者 — エビデンスの薄さを直視する

高齢ICU患者についてSCCM（2026）とESICM（2025）はいずれも強い推奨を出せず、一致したのは老年医学的ケアモデルをICUに組み込むという条件付き推奨だけでした [Beil ICM2026]。

益と負担を語るとき、根拠は年齢ではなく老年症候群の束で、目標は多くの場合、生存期間より生活の質です [Beil ICM2026]。日本のJIPADでは、80歳以上への生命維持治療の使用が施設間で case mix 調整後も約10倍（STR 0.24〜2.34）違い、治療強度の高い施設で生存が良いわけではありませんでした [JIPAD JAMAHealthForum2026]。フレイルの測り方と判断表は「フレイルと高齢重症患者」へ。

13-4. 法で線を引く国、手続きで線を引く国

豪州では差し控えと終了は法的に同等で、家族は無益な治療を要求できず、事前指示書は家族も覆せませんが、無益の判断は担当専門医の合意が条件です [Ueno JIntensiveCare2026]。

手順の向きは4学会合同ガイドラインとほぼ同じで、違いは日本が家族の合意を実務上の要にし、豪州が法で線を引いている点です [Ueno JIntensiveCare2026]。日本には終了・差し控えを定めた法律がなく（§1-4）、実務は対話のプロセスに重心を置く構造にあります。

§14 落とし穴と、まだ決着していないこと — 良い意図が言葉と順番の誤りで害に変わる

ここまでの原則は、実際には一つずつではなく組み合わさって崩れます。この章の結論は、よくある誤りを「なぜ起きるか」と「どう防ぐか」で押さえ、文献の結論が割れている論点は矛盾ではなく次元や場面の違いとして扱う、ということです。

この章のポイント

1. **落とし穴の多くは言葉のすり替えと順番の誤りから起きる**
2. **割れている論点は、どちらが正しいかではなく、次元や場面の違いで読む**
3. **4学会GLの手順がアウトカムを改善するかは、まだ分かっていない**

14-1. よくある10の落とし穴

10の落とし穴を、よくある言葉・行動、なぜ害になるか、代わりの言葉・行動の3列で並べます（表33）。左の列に心当たりがあれば、右の列に置き換えます。

表33｜よくある10の落とし穴 — 言葉と順番を置き換える

よくある言葉・行動	なぜ害になるか	代わりの言葉・行動
① DNARを理由に、心停止前の治療を自動的に控える	様式に範囲が書かれておらず、「もう積極的にはやらない」の省略語として流通しているために起きる	**DNARで決まるのは心停止時の蘇生だけ。挿管・昇圧薬・ICU入室は別に話し合う（§8-1）** [JJAAM2025] [4学会GL2026 Q37]
② 「やめられないから始めない」	終了への法的・心理的な不安から、救えたかもしれない治療を最初から差し控える	**差し控えと終了は倫理的に同等。迷ったらTLTで始めて期日に見直す（§9-1・§9-3）** [4学会GL2026 Q33]
③ 「すべてやりますか」と聞き、スローコードに逃げる	二択が家族にとって苦しく、形だけの蘇生がその逃げ道になる	**心停止の前に処置ごとに話す。形だけの蘇生は選択肢から外す（§8-6）** [Fontenot CCM2026]
④ 悪い知らせの直後に「どうされますか」と決定を求める	沈黙や怒りは理解の悪さではなく生理的な過負荷。その場の答えは本人の価値観を反映しない	**その場で決めさせず、翌日もう一度話す（§7-1）** [Rusinova ICM2026]

よくある言葉・行動	なぜ害になるか	代わりの言葉・行動
⑤ 「決めたのはご家族です」と言う	「死のタイミングに自分が関わった」という決定の重荷が家族に残る	**「医学的に到達した結論をご家族と確認した」と言い、記録もそう残す（§7-3）** [Kentish-Barnes ICM2026]
⑥ 「偽陽性ゼロ」や重症度スコアを、治療制限の根拠にする	分母の小さい「ゼロ」は不確実さを隠す。予測を決定にすり替えている	**予測は情報、決定は価値観。「10人に1人まで外れうる」（良好転帰0/33例の95%上限10.6%）と伝える（§5-3）** [Xu CritCare2026] [Bein ICM2023]
⑦ 「この人はどうせQOLが低い」を前提に置く	障害・高齢・認知症を、能力の欠如や治療の無益に短絡させる	**本人に聞き、補助具を試し、障害のない人と同じ基準を当てる（§5-5・§13）** [Taccone ICM2023]
⑧ 筋弛緩薬を残したまま、薬の準備なしに抜管する	苦しんでいても外から分からず、鎮痛を調整できない	**筋弛緩薬は2時間前（多臓器不全では18時間前）までに止め、苦痛に先回りし、落ち着くまでそばにいる（§10-2・§10-4）** [4学会GL2026 別編]
⑨ 「BSCで」「ここからは緩和で」と言って手を引く	中身が見えず、「見放された」と受け取られる	**何を続け、何をやめ、どう苦痛を取るかを具体的に伝える（§2-2）** [4学会GL2026 説明文]
⑩ 死亡告知と手続きの依頼を、同じ面談で畳みかける	一度に済ませるほうが効率的に見えるが、家族を最も傷つけるのはこの手順の設計	**告知と依頼の間に時間を置き、担当を分ける（§11-3）** [Choi CritCare2026]

14-2. 割れている論点の扱い方 — 矛盾ではなく次元や場面の違い

倫理は「どちらが正しいか」で決まらない領域です。文献の結論が割れている論点を、扱い方とともに並べます（表34）。

表34｜結論が割れている論点 — 矛盾ではなく、次元や場面の違い

論点	割れ方	扱い方
差し控えと終了は同じか	倫理的には同等（4学会GL）／臨床経過は別物（Ethicus-2）	「やめられないから始めない」をしない。記録では項目ごとに書き分ける（§1-1・§9-1）
予後予測を治療制限に使ってよいか	不良マーカー2つ以上で偽陽性ゼロ／良好転帰33例では95%上限10.6%までしか言えない	予測は情報として共有し、決定は価値観で。「偽陽性ゼロ」と言わない（§5-3）
家族への介入は効くのか	陽性の試験／陰性の試験	誰が担ったかで割れている。既存チームの運用に組み込む（§7-7）
DNAR記載を増やすことは良いことか	コーチングで記載は増えた／一律の記載は否定されている	記載の数を成果にしない（§8-7）
ACP・事前指示は実効性があるか	緩和ケアの統合で事前指示は増えた／15カンファで事前指示0名	文書の枚数ではなく、価値観を聴いた記録を見る（§6-4）

まだ分かっていないこと

- 4学会合同ガイドラインの手順が、患者・家族のアウトカムや意思決定の質を改善するか
- 無益性を誰がどう判定するか（無益と「認識された」割合と、無益である割合は別物）
- 家族の心理的アウトカムを改善できる介入があるか
- 高齢ICU患者の意思決定（強い推奨はゼロ）
- パンデミック時のトリアージ・資源配分の枠組み

§15 カルテ記載の文例 — 結論だけでなく、範囲と過程を残す

DNARの有無だけを書いた記録では、合意の範囲も理由も夜勤の看護師に伝わりません。この章の結論は、§9-5の記録項目（表24）とDNARの適用範囲を、コピーして使える形にしておく、ということです [4学会GL2026]。以下は一般論としての文例で、施設の様式に合わせて直して使います。`[ ]`は症例ごとに書き換える箇所です。



DNARの有無だけでは夜勤に伝わらない。範囲と過程を残す。

この章のポイント

1. **DNARは「心停止時は原因を問わず」と範囲で書く**
2. **面談記録には本人の言葉・推定意思の根拠・医療者の推奨を残す**
3. **TLTは目的・期間・評価項目・次の一手を先に書く**

15-1. 文例1 — DNAR指示の範囲

文例1：DNAR指示（範囲を明示する）

【コードステータス】DNAR（心停止時に心肺蘇生を試みない）

・適用範囲：心停止の原因を問わず、胸骨圧迫・除細動・気管挿管・蘇生薬投与を行わない。窒息による心停止を含む。

・例外：**[内視鏡／CV挿入など]**処置に伴う心停止の扱いは、処置前に本人・家族等と確認する。

（今回の取り決め：**[処置中はDNARを一時解除し蘇生を行う／解除しない]**。蘇生後に本人の望む状態に戻れないと判断した場合は、生命維持治療の終了を検討する）

・DNARを理由に控えない治療：酸素投与、輸液、抗菌薬、昇圧薬、**[NIV]**などは適応に応じて継続する。

・心停止前の治療の方針（DNARとは別に決定）：呼吸不全時の気管挿管**[行う／行わない／TLTとして行う]**、透析**[…]**、ICU入室**[…]**

・再評価：**[病状が変化したとき／○月○日／処置の前]**

「原因を問わず」「窒息を含む」「処置に伴う心停止は事前に決める」は、ガイドラインのルールではなく実装の一案です（§8-5）。

15-2. 文例2 — 面談記録（意思決定の過程）

文例2：意思決定の過程（面談記録）

【面談】**[日時]** **[場所]**
参加者：本人 **[参加／不参加（理由：鎮静中など）]**、家族等 **[氏名・続柄]**、医師 **[氏名]**、看護師 **[氏名]**、**[MSW・薬剤師など]**

1. 病状の説明
[病名・経過] を説明した。見通しは **[数日〜数週／数週〜数か月]** の単位で伝えた。
家族等の理解：「**[家族の言葉]**」

2. 本人の価値観・意向
[本人の言葉／家族等が語った本人の言葉]：「**[楽しみ・生きがい・こうなったら生きていたくない状態など、できるだけ逐語で]**」
推定意思の根拠：**[以前の会話・ACP・書面・普段の生活ぶり]**
→ 治療・ケアのゴール：**[苦痛を最小限にして家族と過ごす／自宅に帰れる可能性があれば治療を続ける　など]**

3. 医療・ケアチームの推奨と合意
上記のゴールに照らして、心停止時の心肺蘇生は **[利益がなく苦痛を増やす可能性が高い]** と判断し、行わないことを推奨した。
提案の形：**[informed assent／informed nondissent／推奨し意見を求めた]**。家族等が決定を医療者に委ねたいことを **[確認した]**。
家族等の反応：**[異議なし／同意／保留（理由）]**。質問：**[内容と回答]**

4. チームでの臨床倫理的検討
医学的側面：**[予後・フレイル（CFS ○）・治療の見込み]**
本人の意向：**[上記2]**
QOL：**[回復した場合に予想される状態]**
周囲の状況：**[家族の状況・意見の相違の有無]**

5. 決定事項と保留事項
決定：**[DNAR（文例1の範囲）／挿管は行わない／…]**
保留：**[透析は次回の面談で]**
再評価：**[○月○日、または状態が変化したとき]**

15-3. 文例3 — TLT

文例3：TLT（期限付きの治療の試行）

【TLT】
・目的（本人のゴールとの関係）：**［人工呼吸から離脱し、会話できる状態に戻ること］**
・試行する治療：**［気管挿管・人工呼吸／CRRT］**
・期間：**［7日間］**（再評価日：**［○月○日］**）
・評価項目：**［酸素化の指標・昇圧薬の量・意識レベル・新たな臓器障害］**
・改善した場合：**［継続して、○日後に再評価］**
・改善しない／悪化した場合：**［生命維持治療の終了を含め、ゴールに沿った方針を家族等と話し合う］**
・合意した参加者：**［氏名・続柄・職種］**

15-4. 文例4 — 本人の意思によるDNAR

文例4：本人が自分の価値観で蘇生を望まない場合（終末期でなくても）

本人**［意思決定能力あり：選択の表明・理解・自分のこととしての認識・比較の4過程を確認］**より、「**［本人の言葉］**」との意思表示あり。
病状と、蘇生した場合に予想される経過を説明したうえで、本人の価値観に基づく選択として、心停止時の心肺蘇生を行わない（DNAR、文例1の範囲）。
家族等**［氏名］**と共有**［済／未（予定）］**。

終末期でなくても、本人には生命維持治療を受けるかどうかを選ぶ権利があります [4学会GL2026]。意思決定能力は決定ごとに確かめます（§4-4）。

15-5. 記録で避けること

！記録で避けること

- 「急変時DNR」「DNR取得」— 範囲が曖昧で、急変時に治療全般を控える読み方を招く
- 「家族がDNARを希望」だけを書く — 本人の価値観・推定意思の根拠・医療者の推奨がないと、何を合意したのかが残らない
- チェック欄だけで済ませる — DNARの有無だけでは、合意の範囲と理由が伝わらない
- 「意思決定能力なし」とだけ書く — どの決定について・いつ・どの過程が確認できなかったかを書く（§4-5）
- 重症度スコアや予後予測を治療制限の理由として書く — 予測は共有した情報として、決定は価値観と合意として書く（§5-3）

主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。4学会GL2026は下の1の各分冊（本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編）を指し、Q番号はQ&A集の問いの番号です。文献は、ガイドラインと用語、枠組みと決め方、ACPと話し方と家族支援、DNARと蘇生、選択肢と緩和的抜管、看取りと死の判定、チームのケア、公正と高齢者の順に並べています。

1. 日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会・日本緩和医療学会 編. 救急・集中治療における生命維持治療の終了／差し控えに関する4学会合同ガイドライン（本編・説明文・Q&A集・緩和ケア別編）. 2026年9月.
2. 日本集中治療医学会・日本救急医学会・日本循環器学会. 救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン ～3学会からの提言～. 2014.
3. 厚生労働省. 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（解説編）. 2018年3月改訂.
4. 会田薫子, 小豆畑丈夫, 新井隆男, ほか（日本救急医学会 高齢者救急委員会）. 日本救急医学会 高齢者救急に関する用語の統一概念. 日救急医会誌. 2025;36:82-90.
5. 日本集中治療医学会 倫理委員会. DNAR指示のあり方についての勧告. 日集中医誌. 2017;24:210-215.
6. 日本集中治療医学会 倫理委員会. 委員会報告（2016年12月16日公開）. https://www.jsicm.org/pdf/DNAR20161216_kangae_05.pdf
7. Secunda K, Wirpsa MJ, Neely KJ, et al. Use and Meaning of "Goals of Care" in the Healthcare Literature. J Gen Intern Med. 2020;35(5):1559-1566.
8. Sprung CL, Ricou B, Hartog CS, et al. Changes in End-of-Life Practices in European Intensive Care Units From 1999 to 2016（Ethicus-2）. JAMA. 2019.
9. 伊藤香. 緩和的抜管. 人工呼吸（Jpn J Respir Care）. 2023;40(2):120-125.
10. Jonsen AR, Siegler M, Winslade WJ. Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine.（4分割表）
11. Society of Critical Care Medicine. Fundamental Critical Care Support（FCCS）. 倫理の章.
12. Ganzini L, Volicer L, Nelson WA, Fox E, Derse AR. Ten Myths About Decision-Making Capacity. J Am Med Dir Assoc. 2004;5:263-267.
13. Tarcy T, Kallel H, Giffard M, Besch G, Aubry R. Decision-making process during limitation life-sustaining support meetings in French intensive care units. Intensive Care Med. 2022.
14. Bein T. Avoidance of futile treatment—confluence of human dignity and ecological ethics. Intensive Care Med. 2023;49(9):1145-1146.
15. Xu LX. Neuroprognostication after cardiac arrest: time-anchored reassessment and uncertainty around zero false positives. Crit Care. 2026;30:441.
16. Egawa S, Ader J, Claassen J. Recovery of consciousness after acute brain injury: a narrative review. J Intensive Care. 2024. doi:10.1186/s40560-024-00749-9.
17. Cho YS, Lee DH, Lee BK, et al. Validating the 2025 ERC/ESICM neuroprognostication algorithm using a restricted predictor set in a minimal WLST cohort. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06405-y
18. Hesselink G, Ramakers B, Fikkers BG, et al; PICNL-ICU Study Group. Crit Care Med. 2026;54.
19. Hesselink G, Ramakers B, van Dijk D, Benoit DD, Zegers M; PICNL-ICU study group. Perceived inappropriateness of care among ICU clinicians is associated with burnout and intention to leave the job. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08608-x
20. Taccone FS. Ableism in the intensive care unit. Intensive Care Med. 2023;49(7):898-899.
21. Gerhart KA, Koziol-McLain J, Lowenstein SR, Whiteneck GG. Quality of life following spinal cord injury: knowledge and attitudes of emergency care providers. Ann Emerg Med. 1994;23(4):807-812.
22. Albrecht GL, Devlieger PJ. The disability paradox: high quality of life against all odds. Soc Sci Med. 1999;48(8):977-988.
23. Lu E, Nakagawa S. A "three-stage protocol" for serious illness conversations: reframing communication in real time. Mayo Clin Proc. 2020;95(8):1589-1593.
24. 『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』メジカルビュー社; 2024.（本文の［ACP書籍2024］）
25. Curtis JR, et al. The Importance of Addressing Advance Care Planning and Decisions About Do-Not-Resuscitate Orders During Novel Coronavirus 2019 (COVID-19). JAMA. 2020. PMID 32219360.

26. Elwyn G, et al. Implementing shared decision making in the NHS. BMJ. 2010. PMID 20947577.
27. Auriemma CL, et al. How Traditional Advance Directives Undermine Advance Care Planning: If You Have It in Writing, You Do Not Have to Worry About It. JAMA Intern Med. 2022. PMID 35467697.
28. Rusinova K, Rusina R, Pantilat SZ. Understanding the neuroscience of communicating serious news. Intensive Care Med. 2026.
29. Baile WF, Buckman R, Lenzi R, et al. SPIKES—A six-step protocol for delivering bad news. Oncologist. 2000;5(4):302-311.
30. Kentish-Barnes N, Poujol AL, Banse E, et al. Giving a voice to patients at high risk of dying in the intensive care unit. Intensive Care Med. 2023;49(7):808-819.
31. Maringer EF, Shiland J, Brodie D. Intensive Care Med. 2018;44(6):930-931（ECMOの夫に付き添った妻の記録）.
32. Kentish-Barnes N, Denise T, Renet A, et al. Intensive Care Med. 2026;52:1458-1471（PTSD症状のある家族17人の質的研究）.
33. Choi HR, Zhu L, Lo MS, et al. Family members' experiences of death and organ donation in intensive and critical care units: a qualitative systematic review with thematic synthesis. Crit Care. 2026.
34. Ashana DC, Cox CE. ICU communication: "state of the art". Intensive Care Med. 2026;52(6):1333-1335.
35. Cox CE, et al. Trajectories of palliative care needs among family members of chronically critically ill patients. Crit Care Med. 2023;51(1):13-24.
36. Tuinman PR, Metaxa V. ICU toolbox: negotiation skills for family conversations in the ICU. Intensive Care Med. 2026.
37. Jabaley CS, Brummell Z, Benoit DD, Kentish-Barnes N, Metaxa V. Conflict in intensive care units: a conceptual framework for patient, family, team, and inter-service disagreement. Crit Care. 2026.
38. White DB, Angus DC, Shields AM, et al. A Randomized Trial of a Family-Support Intervention in Intensive Care Units（PARTNER）. N Engl J Med. 2018;378(25):2365-2375.
39. Creutzfeldt CJ, Brumback LC, Im J, et al. Facilitating Communication for Family Members of Critically Ill Patients. Crit Care Med. 2026;54.
40. Li Z, Lu F, Abshire Saylor M, et al. Characteristics and Effectiveness of Nurse-Led Family Communication Interventions in the ICU. Crit Care Med. 2026;54(2):301-311.
41. Kentish-Barnes N, Chevret S, Valade S, et al. A three-step support strategy for relatives of patients dying in the intensive care unit: a cluster randomised trial. Lancet. 2022;399:656-664.
42. Hwang DY, Oczkowski SJW, Lewis K, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines on Family-Centered Care for Adult ICUs: 2024. Crit Care Med. 2025;53(2):e465-e482.
43. Elmer J, et al. Part 3: Ethics: 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2025. PMID 41122890.
44. Burns JP, Truog RD. The DNR Order after 40 Years. N Engl J Med. 2016.
45. Khayat Kakhki S, Daneshfar M, NamaeiQasemnia A, et al. Reimagining resuscitation ethics: a narrative review and emergent ethical pathways model. Resusc Plus. 2026;29:101323.
46. Hamlyn J, et al. Outcomes in adults living with frailty receiving cardiopulmonary resuscitation: A systematic review and meta-analysis. Resusc Plus. 2022. PMID 35812717.
47. Ibitoye SE, et al. Frailty status predicts futility of cardiopulmonary resuscitation in older adults. Age Ageing. 2021. PMID 32500916.
48. Yamamoto R, et al. Frailty and Neurologic Outcomes of Patients Resuscitated From Nontraumatic Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Prospective Observational Study. Ann Emerg Med. 2023. PMID 36964008.
49. Fontenot T, Grisel B, Freeman J, et al. Ethical Implications of the Slow Code: A Systematic Review of Ethics of Slow Codes in U.S. Hospitals. Crit Care Med. 2026;54.
50. Ajzenberg H, Oczkowski SJW. Slow Codes—It's Time for an Honest Approach. Crit Care Med. 2026;54.
51. Wasserman JA, Crutchfield P. Time-limited trials are not an ethical compromise for physiologically futile CPR. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06329-7
52. Benoit DD, De Pauw A, Jacobs C, et al. Coaching doctors to improve ethical decision-making in adult hospitalized patients potentially receiving excessive treatment（CODE）. Intensive Care Med. 2024;50:1635-1646.
53. Quill TE, Holloway R. Time-Limited Trials Near the End of Life. JAMA. 2011;306(13):1483-1484.
54. Kruser JM, Ashana DC, Courtright KR, et al. Defining the Time-limited Trial for Patients with Critical Illness: An Official American Thoracic Society Workshop Report. Ann Am Thorac Soc. 2024;21:187-199.
55. Correia I, Gonçalves Pereira J, Metaxa V. Antibiotics must be part of end-of-life decisions: a necessary evil? Intensive Care Med. 2026.
56. Edwards JD, Voigt LP, Nelson JE. Ten key points about ICU palliative care. Intensive Care Med. 2016.

57. Kesecioglu J, Metaxa V, Azoulay E. Surviving Sepsis Campaign beyond survival: aligning sepsis care with patient goals. Intensive Care Med. 2026.
58. Kesecioglu J, Rusinova K, Alampi D, et al. ESICM guidelines on end of life and palliative care in the ICU. Intensive Care Med. 2024;50:1740-1766.
59. Downar J, Delaney JW, Hawryluck L, et al. Guidelines for the withdrawal of life-sustaining measures. Intensive Care Med. 2016;42:1003-1017.
60. Cooke CR, Hotchkin DL, Engelberg RA, et al. Predictors of time to death after terminal withdrawal of mechanical ventilation in the ICU. Chest. 2010;138:289-297.
61. Durán-Crane A, Laserna A, López-Olivo MA, et al. Clinical practice guidelines and consensus statements about pain management in critically ill end-of-life patients: a systematic review. Crit Care Med. 2019;47(11):1619-1626.
62. Sakuramoto H, Hatozaki C, Unoki T, et al. Translation, reliability, and validity of Japanese version of the Respiratory Distress Observation Scale. PLoS One. 2021;16:e0255991.
63. Hubel K, Reddy R, Khan A, Pak J, Sher N. Compassionate Extracorporeal Membrane Oxygenation Discontinuation: A Narrative Review and Practical Process Model for Reliable End-of-Life Care. Healthcare (Basel). 2026;14:1249.
64. Le Dorze M, Nicolas-Robin A, Carvallo S, Maglio M, Molina-Pérez A. Death determination at the bedside: clinical judgement beyond criteria. Crit Care. 2026.
65. Oppenheim IM, Bakhru RN, Maciel CB, Busl KM; DONOR Group. Crit Care Explor. 2026;8(8):e1458（心停止後臓器提供でも終末期ケアの質を変えない）.
66. Wu A, Hirsch KG, Magnus D. Communicating With Families About Brain Death. JAMA. Published online September 2, 2026.
67. Brender TD, Axelrod JK, Weiss Goitiandia S, Batten JN, Dzeng EW. Clinicians' Perceptions About Institutional Factors in Moral Distress Related to Potentially Nonbeneficial Treatments. JAMA Netw Open. 2025;8(6):e2516089.
68. Qu KY, Zhu DJ, Yang PF, et al. Moral distress of intensive care unit nurses: a systematic review and meta-analysis. BMC Nurs. 2026;25:108.
69. Renet A, Azoulay E, Reignier J, et al. "It's all about setting the stage." The nurse facilitator trial: perceived outcomes and implementation issues. Intensive Care Med. 2024;50(10):1657-1667.
70. Fujii T, Katayama S, Miyazaki K, et al. Translation and validation of the Japanese version of the measure of moral distress for healthcare professionals. Health Qual Life Outcomes. 2021;19:120.
71. Beil M, Jung C, Guidet B. Negotiating complexity in spite of scarce evidence—how to care for older ICU patients? Intensive Care Med. 2026;52(8):1793-1795.
72. Ueno R, Modra L, Warrillow S. Culture, ethics and clinical practice for intensivists managing end of life care: an Australian perspective. J Intensive Care. 2026;14:19.

最終更新日：2026-10-14（「最新の動き」は随時更新）